AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Repaso de última hora

DERMATOLOGÍA

18 temas · 1 página cada uno

Psoriasis, Cáncer de piel & NET

7 temas ★★★ según preguntas reales 2013–2025 · plan de repaso de 7 días

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Semiología Cutánea, Acné, Rosácea & Alopecias

★★☆ 16.1. Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel 3
★☆☆ 16.2. Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína 4
★★☆ 16.3. Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico 5
★★☆ 16.4. Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno 6

02 Dermatosis Inflamatorias, Psoriasis & Eccemas

★★★ 16.5. Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas GES 7
★★☆ 16.6. Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación 9
★★★ 16.7. Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa) 10
★★★ 16.8. Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos 11

03 Farmacodermias Graves & Enfermedades Ampollares

★★★ 16.9. Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) 12
★★☆ 16.10. Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos 13
★☆☆ 16.11. Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) 15
★★★ 16.12. Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple 17

04 Oncología Cutánea, Lesiones Premalignas & Infecciones Cutáneas

★★☆ 16.13. Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos GES 18
★★☆ 16.14. Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) GES 20
★★☆ 16.15. Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos 21
★★★ 16.16. Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis 22
★★★ 16.17. Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares 23
★★☆ 16.18. Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda 24

Números que tienes que saber 25
Fármacos de primera línea 27
GES de la especialidad 27
Plan de repaso de 7 días 29
Índice por prioridad ★ 30

BLOQUE 01 · SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

16.1 Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
1 pregunta real 2013–2025

6.01.3.003	Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas	Conocimiento general
6.01.1.009	Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.01.1.032	Vitiligo	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Mácula < **1 cm** plana; Mancha > **1 cm** plana (ambas sin relieve detectable a la palpación).
- Pápula < **1 cm** sólida; Placa > **1 cm** sólida en meseta (confluye de pápulas).
- **Nódulo** = lesión sólida profunda hipodérmica que se palpa más de lo que se ve.
- **Habón o roncha** = placa edematosa evanescente que dura menos de **24 horas**.
- Vesícula < **0.5 cm** líquida; Ampolla > **0.5 cm** líquida.
- La erosión compromete solo epidermis y CURA SIN CICATRIZ; la úlcera compromete dermis y DEJA CICATRIZ.



MANCHA CAFÉ CON LECHE
Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 622

ALGORITMO · LESIÓN CUTÁNEA: NOMBRA LO QUE VES

☐ urgencia ☐ resuelve ☐ derivar ☐ examen/acción

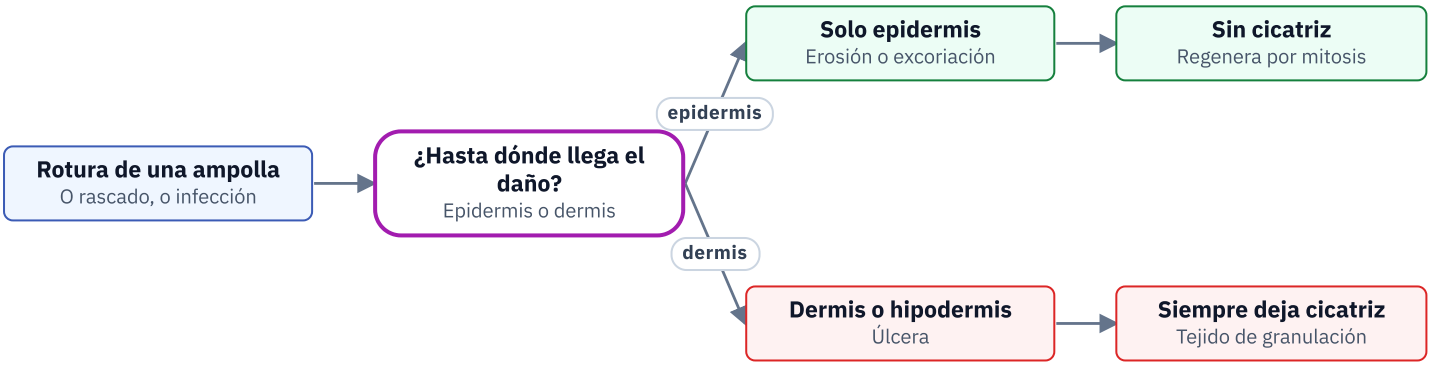


TABLA 16.1 · RESUMEN TAXONÓMICO DE LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS VS SECUNDARIAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-01

LESIÓN	TIPO / CONTENIDO	TAMAÑO DE CORTE	NIVEL ANATÓMICO	EJEMPLO CLÍNICO TÍPICO
Mácula	Plana (cambio color)	< 1.0 cm	Epidérmica / Dérmica	Efélide (peca), petequia
Mancha	Plana (cambio color)	> 1.0 cm	Epidérmica / Dérmica	Vitíligo, mancha mongólica
Pápula	Sólida sobreelevada	< 1.0 cm	Epidermis / Dermis superficial	Acné pápula, liquen plano
Placa	Sólida en meseta	> 1.0 cm	Epidermis / Dermis	Psoriasis en placas
Nódulo	Sólido circunscrito	> 1.0 cm	Dermis profunda / Hipodermis	Eritema nudoso
Habón / Roncha	Edema dérmico evanescente	Variable	Dermis papilar/reticular	Urticaria aguda (< 24 horas)
Vesícula	Líquido seroso/hemático	< 0.5 cm	Intra / Subepidérmico	Herpes simple, varicela
Ampolla	Líquido seroso/hemático	> 0.5 – 1.0 cm	Intra / Subepidérmico	Penfigoide ampollar, quemadura
Erosión	Pérdida superficial	Variable	Solo Epidermis (SIN cicatriz)	Ampolla desnudada
Úlcera	Pérdida profunda	Variable	Llega a Dermis (CON cicatriz)	Úlcera varicosa venosa

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase derma-01

PAR	EL CORTE	ERROR FRECUENTE
Eritema nudoso vs Bazin	Pretibial sin úlcera vs pantorrilla que se ulcera	Tratar un Bazin como eritema nudoso, sin biopsia
Vitíligo vs pitiriasis versicolor	Acrómico sin escama vs hipocrómico que descama	No pedir TSH ni anticuerpos antiperoxidasa en el vitíligo

REGLA DE ORO **Mácula/mancha: 1 cm** — Vesícula/ampolla: 0,5 cm

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **2, 4–8** (págs. 10–11) · solucionario págs. 23–24.

Clase 16.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

16.2 Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

6.01.1.001 Acné — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

2.01.1.104 Acné — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El comedón es la lesión elemental obligatoria que define al acné vulgar.
- **Acné comedoniano** = Retinoide tópico de elección (Adapaleno o Tretinoína).
- NUNCA usar antibióticos tópicos en monoterapia; asociar siempre a Peróxido de Benzoilo.
- **Acné inflamatorio moderado-severo** = Tetraciclinas orales (Doxiciclina **100 mg**/día) por **8 a 12 semanas**.
- La Isotretinoína oral se indica en acné nódulo-quístico severo, cicatrizante o refractario.
- **La Isotretinoína es teratogénica absoluta**: exige doble anticoncepción y control lipídico/hepático.



COMEDONES
Fitzpatrick 7.ª ed., p. 66

ALGORITMO · ACNÉ VULGAR: ESCALONAMIENTO TERAPÉUTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

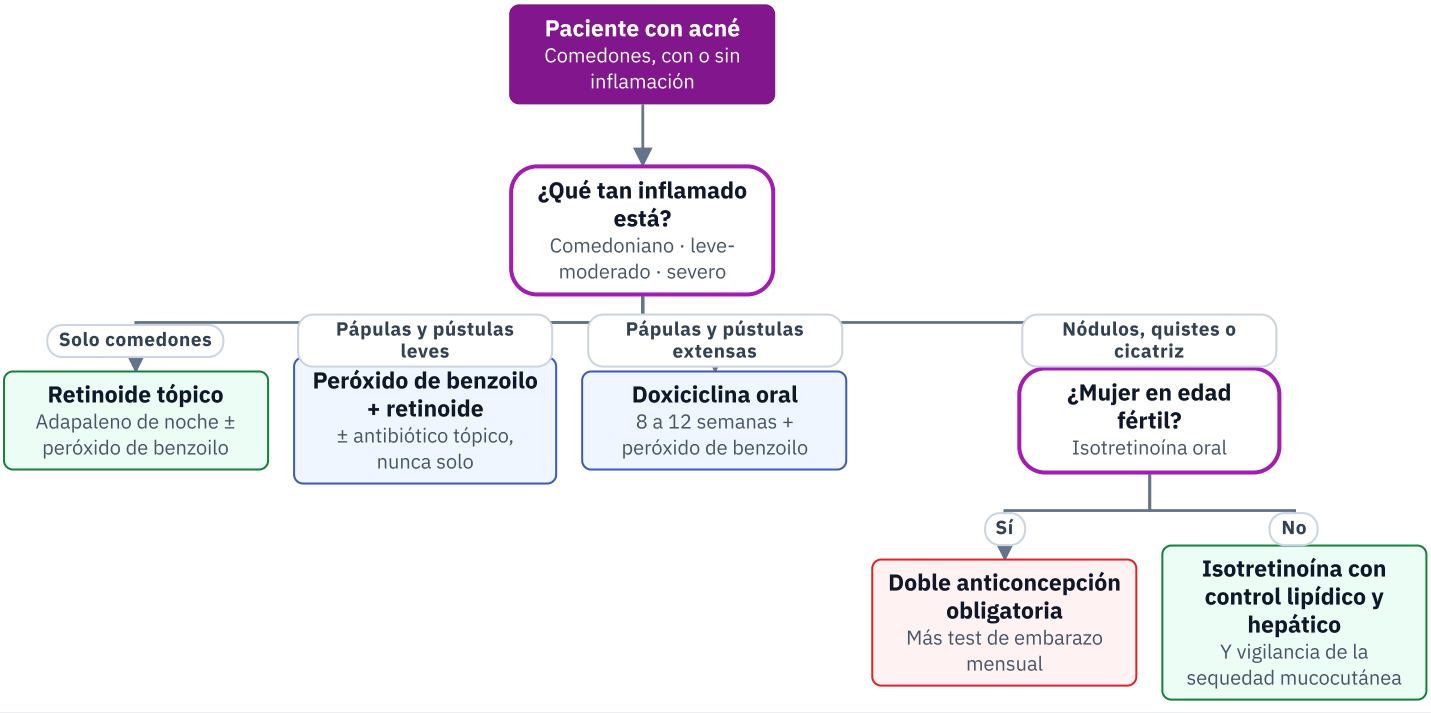


TABLA 16.2 · ALGORITMO ESCALONADO DE TRATAMIENTO DEL ACNÉ VULGAR

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-02

GRADO / SEVERIDAD	LESIONES PREDOMINANTES	TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA	ALTERNATIVA / COADYUVANTE
Acné Comedoniano	Comedones abiertos y cerrados	Retinoide tópico (Adapaleno 0.1%) nocturno	Peróxido de benzoilo 2.5-5% / Ácido azelaico
Acné Pápulo-pustuloso Leve	Comedones + pápulas inflamatorias	Peróxido de benzoilo + Retinoide tópico	Asociar Clindamicina tópica 1% combinada
Acné Pápulo-pustuloso Moderado	Pápulas y pústulas numerosas en cara/espalda	Doxiciclina oral 100 mg/día + Peróxido de benzoilo	Minociclina oral / Terapia combinada tópica
Acné Severo / Nódulo-quístico	Nódulos profundos, quistes, cicatrices	ISOTRETINOÍNA ORAL (0.5 a 1.0 mg/kg/día)	Doble anticoncepción + monitoreo lipídico/hepático

REGLA DE ORO **Comedoniano: retinoide tópico** — Leve-moderado: sumar peróxido de benzoilo

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **9–11** (pág. 11) · solucionario pág. 24.

Clase 16.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

16.3 Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
1 pregunta real 2013–2025

6.01.1.026 Rosácea — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La rosácea NUNCA TIENE COMEDONES (la presencia de comedones define acné).
- **Desencadenantes clásicos**: sol, calor, alcohol, comidas picantes y estrés.
- **Subtipo 1** = eritema y telangiectasias; Subtipo 2 = pápulas y pústulas; Subtipo 3 = Rinofima.
- El tratamiento tópico de primera línea en la rosácea pápulo-pustulosa es Metronidazol o Ivermectina.
- Si es moderada-severa, se indica Doxiciclina oral a dosis antiinflamatorias.
- **PROHIBICIÓN ABSOLUTA**: JAMÁS usar corticoides tópicos en rosácea (inducen rosácea esteroidal severa).



ROSÁCEA
Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 60

ALGORITMO · ROSÁCEA: DEL SUBTIPO AL TRATAMIENTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

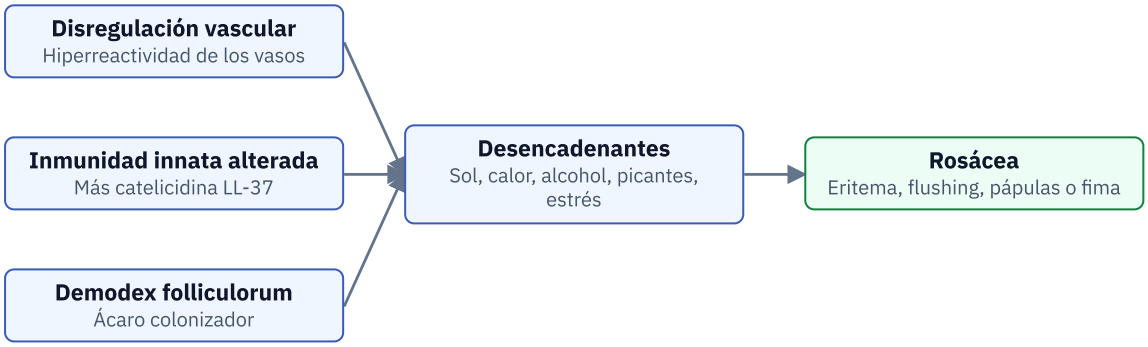


TABLA 16.3 · SUBTIPOS CLÍNICOS DE ROSÁCEA Y TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-03

SUBTIPO	HALLAZGO CLÍNICO PREDOMINANTE	TRATAMIENTO TÓPICO	TRATAMIENTO ORAL / PROCEDIMIENTO
1. Eritematotelangiectásica	Eritema centrofacial fijo + flushing + telangiectasias	Brimonidina tópica / Fotoprotector 50+	Láser vascular / Luz Pulsada Intensa (IPL)
2. Pápulo-pustulosa	Pápulas y pústulas centrofaciales SIN comedones	Metronidazol 0.75% / Ivermectina 1% tópica	Doxiciclina oral 100 mg/día (8 a 12 semanas)
3. Fimatosa (Rinofima)	Engrosamiento nasal bulboso, poros dilatados	Ineficaz en estadios fibrosos avanzados	Resección quirúrgica / Láser CO_2 ablativo
4. Ocular	Blefaritis, ardor, ojo seco, chalazión recurrente	Higiene de párpados + lágrimas artificiales	Doxiciclina oral a dosis bajas por 6 semanas

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase derma-03

SITUACIÓN	CORRECTO	ERROR FRECUENTE
Eritema facial con pápulas	Buscar comedones antes de decidir	Diagnosticar acné del adulto sin revisar
Rinofima establecido	Cirugía o láser ablativo	Insistir con tratamiento médico
Síntomas oculares con antecedente de rosácea	Higiene palpebral + doxiciclina oral	Tratarlo solo como conjuntivitis

REGLA DE ORO — **La rosácea nunca tiene comedones** — Si hay comedones, es acné

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **12–16** (págs. 11–12) · solucionario págs. 24–25.

Clase 16.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

16.4 Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
1 pregunta real 2013–2025

6.01.1.002 Alopecías — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Alopecia no cicatricial** = orificios foliculares conservados (potencialmente reversible).
- **Alopecia cicatricial** = piel lisa y brillante sin orificios foliculares (irreversible de por vida).
- **Alopecia androgenética** = miniaturización mediada por dihidrotestosterona; responde a Finasteride y Minoxidil.
- El Finasteride está contraindicado en mujeres en edad fértil por teratogenicidad (feminización fetal).
- **Alopecia areata** = placas alopécicas redondas con pelos en "signo de exclamación"; responde a corticoides intralesionales.
- **Efluvio telógeno** = caída difusa **2 a 3 meses** post-estrés (parto, fiebre alta, cirugía); se resuelve solo.



ESCALA DE HAMILTON
Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 62

ALGORITMO · ALOPECIA: DEL ORIFICIO FOLICULAR A LA CAUSA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

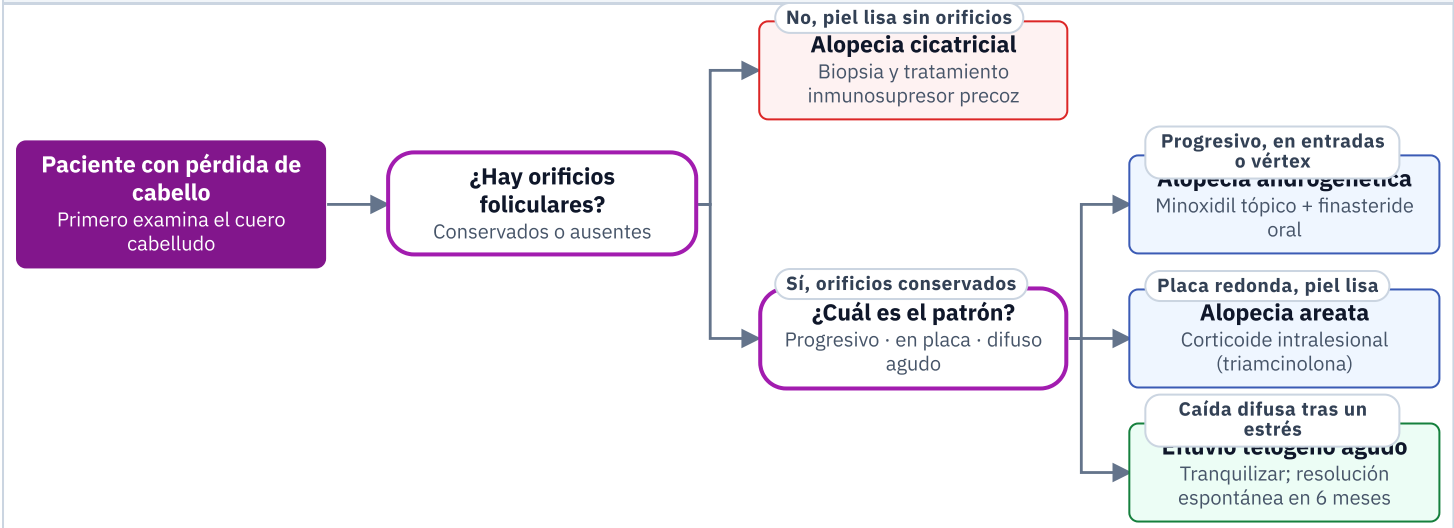


TABLA 16.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ALOPECIA ANDROGENÉTICA VS AREATA VS EFLUVIO TELÓGENO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-04

CARACTERÍSTICA	ALOPECIA ANDROGENÉTICA	ALOPECIA AREATA	EFLUVIO TELÓGENO
Mecanismo fisiopatológico	Miniaturización folicular por Dihidrotestosterona	Ataque autoinmune mediado por linfocitos T	Paso sincrónico a telógeno tras estrés agudo
Patrón de distribución	Entradas frontotemporales y coronilla (Ludwig fem)	Placas alopécicas redondeadas bien delimitadas	Caída DIFUSA de todo el cuero cabelludo
Aspecto de la piel	Normal, con orificios foliculares y vellos finos	Piel completamente lisa, limpia, sin escama	Normal, sin placas circunscritas
Signo semiológico clave	Miniaturización progresiva en dermoscopía	PELOS EN SIGNO DE EXCLAMACIÓN en el borde	Pull test positivo difuso (> 10 pelos con bulbo)
Asociación sistémica	Síndrome metabólico, herencia poligénica	Tiroiditis de Hashimoto, vitíligo, atopia	Parto, cirugía, fiebre alta 2-3 meses antes
Tratamiento de elección	Minoxidil tópico 5% + Finasteride oral 1 mg	Corticoides intralesionales (Triamcinolona)	Tranquilizar al paciente; resolución espontánea

REGLA DE ORO **Orificios conservados: reversible** — Sin orificios: cicatricial, irreversible

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **17–18** (pág. 12) · solucionario pág. 25.

Clase 16.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS TIER 3

16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

Máxima rentabilidad · Tríada semiológica de Brocq, Koebner, artritis psoriásica y contraindicación de corticoides sistémicos

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud: Psoriasis Moderada a Grave en personas de 15 años y más (GES N° 84)

6.01.1.024	Psoriasis	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Completo
6.01.1.015	Líquen plano	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.11.1.001	Artritis psoriática	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
6.01.2.004	Eritrodermia	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

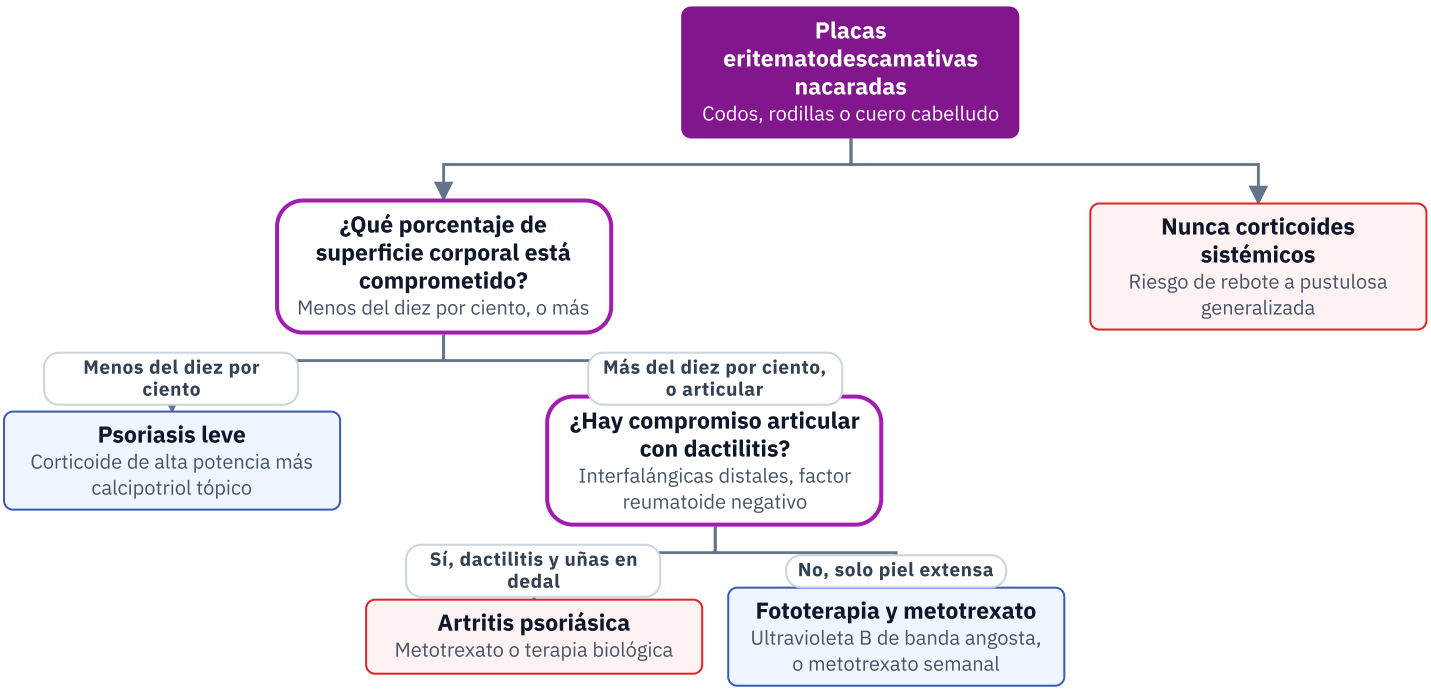
- El raspado metódico de Brocq culmina en el Signo de Auspitz (rocío sangrante patognomónico).
- El fenómeno de Koebner es la aparición de lesiones psoriásicas típicas sobre piel sana traumatizada.
- La psoriasis en placas típica se ubica en superficies de extensión: codos, rodillas y región lumbosacra.
- La psoriasis en gotas ocurre en jóvenes tras una faringoamigdalitis estreptocócica.
- El tratamiento tópico de elección es la combinación fija de Corticoide potente + Calcipotriol.
- La psoriasis moderada-grave ingresa a garantías GES N° 84 (fototerapia, metotrexato y biológicos).
- **CONTRAINDICACIÓN FATAL**: NUNCA usar corticoides orales o parenterales (causan rebote a psoriasis pustulosa letal).



PLACAS PSORIÁSICAS
Manual AMIR Dermatología, p. 39

ALGORITMO · PSORIASIS: DE LA PLACA AL ESCALÓN TERAPÉUTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **24–29, 37** (págs. 13–15) · solucionario págs. 26–28.

Clase 16.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 16.5 · FORMAS CLÍNICAS DE PSORIASIS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL — = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-05

FORMA CLÍNICA	LOCALIZACIÓN / LESIÓN ELEMENTAL	DESENCADENANTE TÍPICO	CONDUCTA TERAPÉUTICA
En Placas (Vulgar, 85%)	Placas eritematosas con escamas nacaradas en codos/rodillas	Trauma local (Koebner), estrés, tabaco	Tópicos (Clobetasol + Calcipotriol) / MTX
En Gotas (Guttata)	Pápulas descamativas en gotas en tronco de niños/jóvenes	Infección estreptocócica faríngea previa	Amoxicilina/Penicilina + Fototerapia UVB
Invertida	Placas rojas lisas SIN escamas en axilas/ingles	Fricción y maceración en pliegues	Inhibidores de calcineurina / corticoides suaves
Pustulosa Generalizada	Pústulas estériles confluentes + fiebre alta	SUSPENSIÓN DE CORTICOIDES ORALES	Hospitalización urgente + Acitretina / Infliximab
Artropatía Psoriásica	Dactilitis ("dedo en salchicha") + artritis IFD	Antígeno HLA-B27, factor reumatoide (-)	Metotrexato o Biológicos anti-TNF / anti-IL17

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA — clase derma-05

FORMA CLÍNICA	LESIÓN Y LOCALIZACIÓN	GATILLANTE TÍPICO	CONDUCTA
Eritrodermia	Eritema y descamación de más del 90% de la piel	Psoriasis, atopia, toxidermia, Sézary	Hospitalizar; nunca corticoides orales
Líquen plano	Pápulas violáceas con estrías de Wickham	Hepatitis C, IECA, tiazidas	Clobetasol; oral erosivo, derivar

REGLA DE ORO — **Auspitz es patognomónico** — Rocío sangrante tras la membrana despegable

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica inmunomediada crónica caracterizada por hiperproliferación epidérmica acelerada. En el examen se evalúan tres áreas esenciales: la semiología del raspado metódico de Brocq con el signo de Auspitz, el fenómeno de Koebner, y la prohibición estricta de prescribir corticoides sistémicos.

TABLA 16.5.B · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO EN PSORIASIS VULGAR

ESCALÓN	FÁRMACO / MODALIDAD	MECANISMO DE ACCIÓN	PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD
1. Tópico	Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona ungüento	Sinergia antiproliferativa y antiinflamatoria	No exceder 100 g/semana por riesgo de hipercalcemia
2. Fototerapia	Radiación Ultravioleta B de banda estrecha (UVB-NB)	Inmunomodulación dérmica y apoptosis linfocitaria	Contraindicado en melanoma previo o lupus
3. Sistémico clásico	Metotrexato 15-25 mg oral 1 vez por semana + Ácido fólico	Antagonista de folatos; frena replicación celular	Hepatotoxicidad, mielosupresión; pedir hemograma y perfil
4. Sistémico oral 2	Acitretina 25-50 mg/día oral (retinoide)	Regula la diferenciación epidérmica en pustulosa	TERATOGÉNICO: prohibido embarazo por 3 años post-uso
5. Biológico	Anti-IL-17 (Secukinumab) o Anti-IL-23 (Ustekinumab)	Bloqueo selectivo de la cascada citoquínica Th17	Descartar Tuberculosis latente (PPD/QuantiFERON) previa

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **24–29, 37** (págs. 13–15) · solucionario págs. 26–28.

Clase 16.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

16.6 Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

Muy alta · Criterio cardinal de prurito, distribución anatómica por edad y manejo de base

6.01.1.004	Dermatitis atópica	Dx Específico	Tx Completo	Seg Derivar

2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El PRURITO INTENSO es el criterio diagnóstico cardinal obligatorio de dermatitis atópica.
- En el lactante afecta mejillas y convexidades, y RESPETA ESTRICTAMENTE el área del pañal.
- En niños mayores y adultos se localiza en los PLIEGUES FLEXURALES (fosas antecubitales y poplíteas).
- La base terapéutica de por vida son los emolientes e hidratantes diarios ("soak and seal").
- En brotes se usan corticoides tópicos (baja potencia en cara/pliegues como hidrocortisona; alta en cuerpo).
- El Eccema herpético de Kaposi (vesículas umbilicadas + fiebre) requiere Aciclovir EV urgente.



LACTANTE
Fitzpatrick 7.ª ed., p. 189

ALGORITMO · DERMATITIS ATÓPICA: DEL PRURITO A LA COMPLICACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

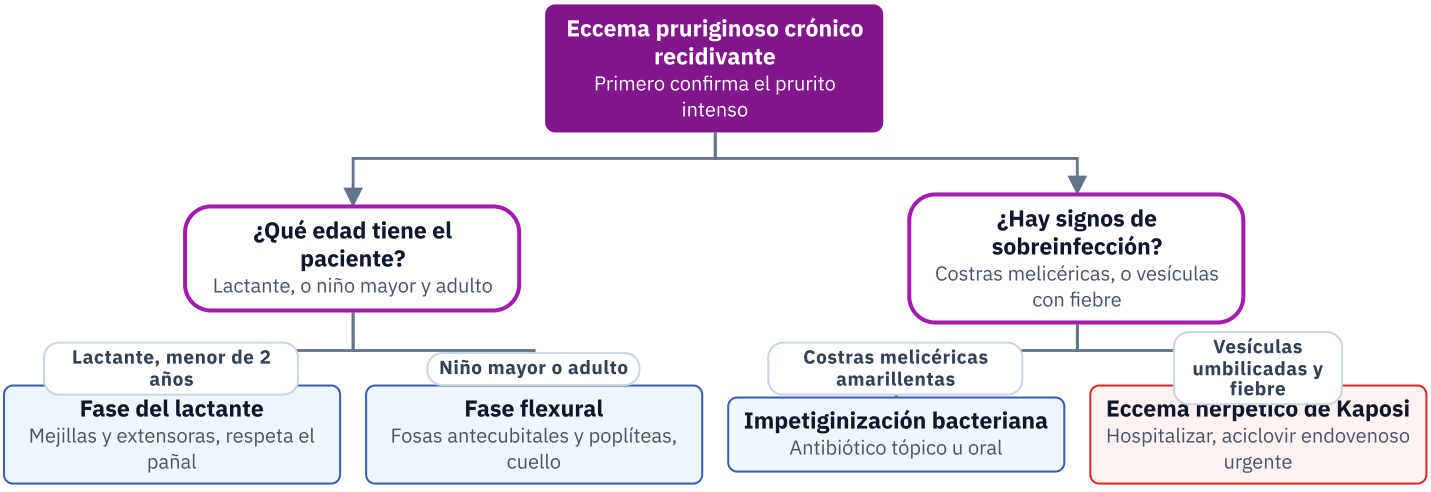


TABLA 16.6 · TOPOGRAFÍA DE LA DERMATITIS ATÓPICA SEGÚN GRUPO ETARIO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-06

ETAPA ETARIA	LOCALIZACIÓN CUTÁNEA CLÁSICA	TIPO DE LESIÓN PREDOMINANTE	ZONA RESPETADA TÍPICA
Lactante (< 2 años)	Mejillas, cuero cabelludo, caras extensoras	Eccema agudo exudativo, eritema y costras	RESPETA EL ÁREA DEL PAÑAL y triángulo perioral
Infantil (2 a 12 años)	Pliegues flexurales (fosa antecubital y poplítea)	Pápulas descamativas, liquenificación leve	Menor compromiso facial que en lactantes
Adulto (> 12 años)	Pliegues de flexión, cuello, manos y párpados	Placas liquenificadas secas por rascado crónico	Tronco suele estar menos afectado

REGLA DE ORO **Sin prurito intenso, no hay dermatitis atópica** — Es el criterio cardinal de Hanifin y Rajka

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **30–32** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

Clase 16.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

6.01.1.006	Dermatitis seborreica infantil y del adulto	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	6.01.1.007	Dermitis de contacto	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
6.01.4.005	Patch test	Interpreta y emplea	6.01.1.005	Dermatitis del pañal	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
6.01.1.011	Fotodermatosis	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo	2.01.1.108	Dermatitis del pañal y de contacto	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La dermatitis seborreica cursa con escamas amarillentas untuosas en surcos nasogenianos y cuero cabelludo.
- Dermatitis seborreica severa y refractaria en adultos jóvenes obliga a descartar infección por VIH o Parkinson.
- **Dermatitis de contacto irritativa (80%)** = daño tóxico no inmune con ardor/fisuras delimitado a la zona de contacto.
- **Dermatitis de contacto alérgica (20%)** = hipersensibilidad tipo IV con prurito intenso que sobrepasa el área de contacto.
- El alérgeno más frecuente es el NÍQUEL (bisutería, hebillas, botones de jeans).

ALGORITMO · ECCEMAS: DE LA LOCALIZACIÓN AL DIAGNÓSTICO CONFIRMADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

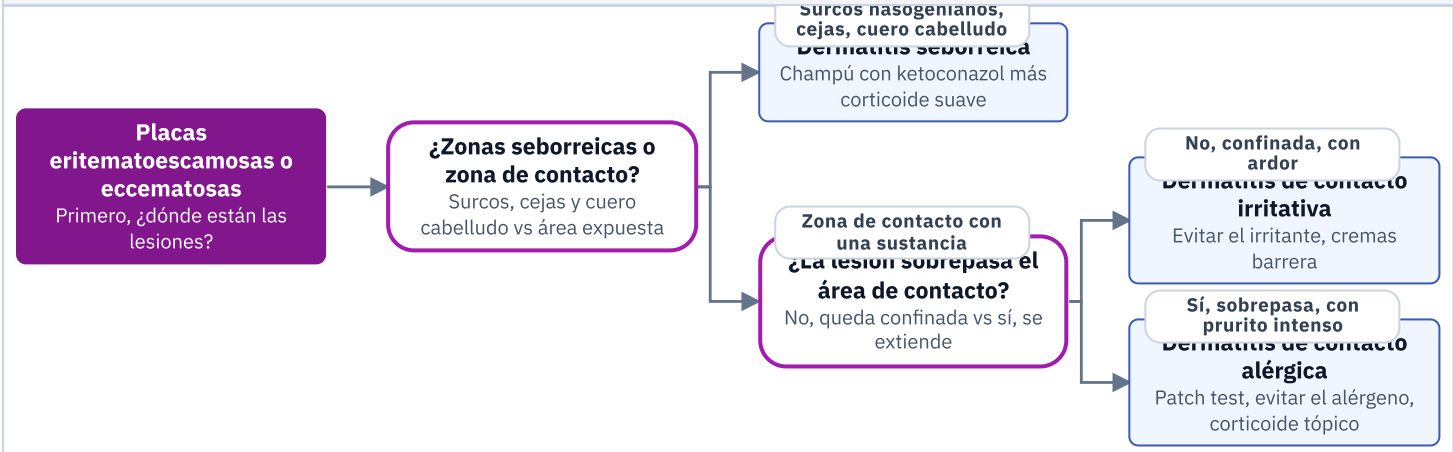


TABLA 16.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: CONTACTO IRRITATIVA VS CONTACTO ALÉRGICA VS SEBORREICA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-07

CRITERIO	CONTACTO IRRITATIVA (80%)	CONTACTO ALÉRGICA (20%)	DERMATITIS SEBORREICA
Mecanismo etiopatogénico	Daño tóxico celular directo no inmune	Hipersensibilidad retardada Tipo IV (linfocitos T)	Respuesta inmune a levadura Malassezia
Sensibilización previa	NO requiere; le ocurre a cualquiera	SÍ requiere sensibilización previa	No aplica (flora comensal comúnmente presente)
Síntoma cardinal	Ardor, quemazón, tirantez dolorosa	PRURITO INTENSO y continuo	Prurito leve o asintomático
Límites de las lesiones	Confinadas estrictamente al área de contacto	SOBREPASAN los límites del contacto	Zonas seborreicas (surcos, cejas, tórax)
Aspecto de la escama	Escama seca, fisurada, agrietada	Eccema microvesicular exudativo	Escamas GRASOSAS, untuosas, amarillentas
Pruebas del parche (Patch test)	NEGATIVAS (sin reacción alérgica)	POSITIVAS a las 48 y 96 horas	No indicadas
Tratamiento de elección	Evitar irritante + cremas barrera	Evitar alérgeno + Corticoide tópico	Champú Ketoconazol 2% + corticoide suave

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase derma-07

CRITERIO	CONTACTO IRRITATIVA	CONTACTO ALÉRGICA	SEBORREICA
Límites de la lesión	Confinada al contacto	Sobrepasa el contacto	Zonas seborreicas

REGLA DE ORO **Zonas seborreicas: piensa en Malassezia** — Zona de contacto: piensa en irritante o alérgeno

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **1, 33–36** (págs. 10, 14) · solucionario págs. 23, 27–28.

Clase 16.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

6.01.1.030	Urticaria aguda	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
6.01.2.001	Angioedema de Quinque	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
2.01.1.055	Alergias	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
6.01.2.016	Urticaria y angioedema	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El habón o roncha es EVANESCENTE**: dura menos de **24 horas** y desaparece sin dejar rastro.
- Si el habón dura más de **24 horas** o deja mancha purpúrica residual, es Vasculitis Urticariana (requiere biopsia).
- Urticaria aguda < **6 semanas** (desencadenada por virus o fármacos); Urticaria crónica **≥ 6 semanas** (autoinmune).
- **Primera línea**: Antihistamínicos H1 de 2.ª generación no sedantes (Cetirizina, Desloratadina, Levocetirizina).
- **Si no responde en 2 a 4 semanas**: CUADRUPLICAR la dosis del antihistamínico H1 de 2.ª generación (hasta **4 veces**).
- En ANAFILAXIA (compromiso de vía aérea o hipotensión), el tratamiento inmediato vital es ADRENALINA INTRAMUSCULAR.



HABONES
Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 49

ALGORITMO · URTICARIA: DE LA EVALUACIÓN DE URGENCIA AL ESCALONAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

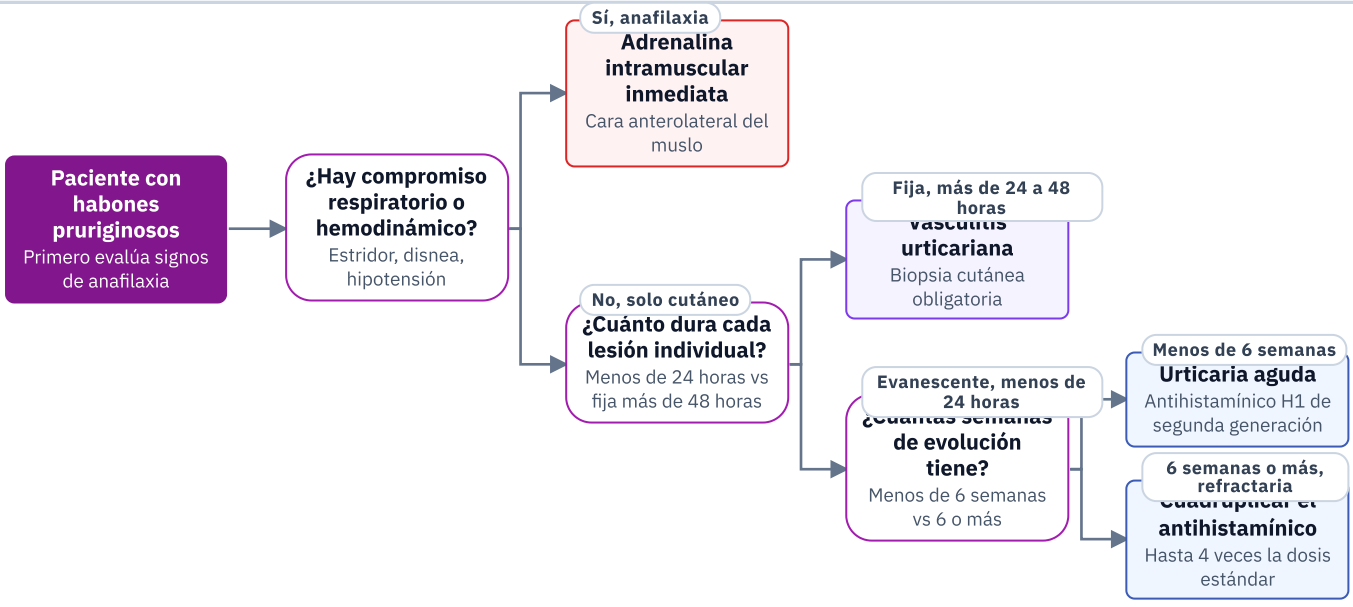


TABLA 16.8 · URTICARIA COMÚN VS VASCULITIS URTICARIANA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-08

PARÁMETRO	URTICARIA COMÚN (AGUDA O CRÓNICA)	VASCULITIS URTICARIANA
Duración de cada lesión individual	EVANESCENTE: desaparece en < 24 HORAS	FIJA: persiste MÁS DE 24 a 48 HORAS
Síntoma subjetivo predominante	PRURITO INTENSO (picazón)	ARDOR, dolor, quemazón o sensibilidad
Evolución al resolverse	Desaparece sin dejar NINGUNA marca	Deja PÚRPURA o mancha pigmentaria residual
Fisiopatología	Degranulación mastocitaria e histamina	Vasculitis leucocitoclástica por inmunocomplejos
Estudio diagnóstico	Clínico; no requiere biopsia	BIOPSIA CUTÁNEA OBLIGATORIA (estudio de LES/hipocomplementemia)

REGLA DE ORO **Menos de 24 horas, sin marca** — Si es fijo, piensa en vasculitis urticariana

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **45–48, 75** (págs. 16, 21) · solucionario págs. 29–30, 34.

Clase 16.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES TIER 3

16.9 Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

★★★ PRIORIDAD ALTA
4 preguntas reales 2013–2025

6.01.2.015	Síndrome de Stevens-Johnson	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
6.01.2.009	Necrolisis tóxica epidérmica	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
6.01.2.014	Síndrome de piel escaldada por estafilococos	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg No requiere

LO QUE TE PREGUNTAN

- Los fármacos gatillantes más frecuentes son Alopurinol, Carbamazepina, Cotrimoxazol y AINEs.
- El período de latencia típico es de **1 a 4 semanas** tras el inicio del fármaco culpable.
- El Signo de Nikolsky (+) es el desprendimiento de la epidermis por fricción suave sobre piel eritematosa.
- **Clasificación por superficie corporal desprendida**: SSJ < **10%**; Superposición SSJ/NET **10-30%**; NET > **30%**.
- El score SCORTEN (7 parámetros dentro de las primeras **48 h**) estima con precisión la mortalidad.



DIANAS ATÍPICAS
Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., p. 414

ALGORITMO · SSJ Y NET: DE LA SOSPECHA AL DESTINO DE HOSPITALIZACIÓN

☐ urgencia ☐ resuelve ☐ derivar ☐ examen/acción

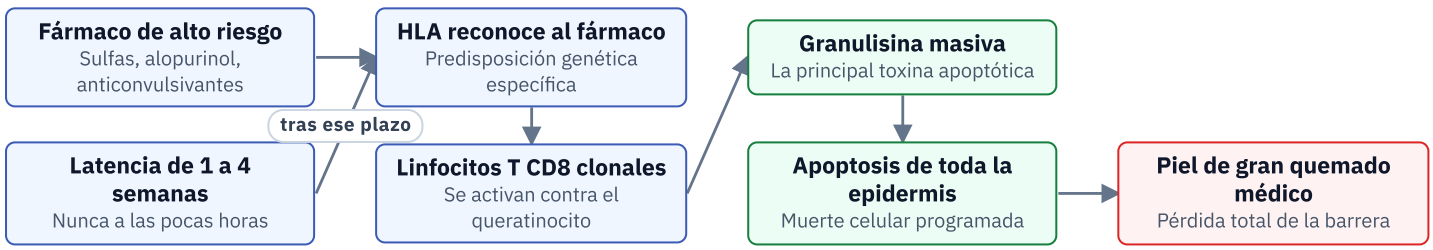


TABLA 16.9 · CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL ESPECTRO SSJ / NET

PARÁMETRO	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON (SSJ)	SUPERPOSICIÓN SSJ / NET	NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA (NET)
Porcentaje de BSA Desprendida	< 10% de la piel total	10% a 30% de la piel total	> 30% de la piel total (hasta > 80%)
Tipo de Lesión Cutánea	Máculas en dianas atípicas purpúricas y flictenas	Dianas atípicas confluentes con ampollas extensas	Desprendimiento en sábanas completas (escaldadura)
Compromiso de Mucosas	Grave (≥ 2 mucosas en > 95%)	Grave y constante (oral, genital, conjuntival)	Masivo y hemorrágico difuso con necrosis traqueobronquial
Signo de Nikolsky	Positivo (+) en áreas eritematosas	Positivo (+) ampliamente distribuido	Positivo (+) generalizado en casi toda la superficie
Mortalidad Estimada	1% a 5%	10% a 15%	30% a 50% (por sepsis y shock distributivo)

TRAMPAS EUNACOM

clase derma-09

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Desprendimiento menor a 10% con 2 mucosas	Suspender el fármaco y hospitalizar	Tratar como una alergia leve con antihistamínico
Desprendimiento mayor a 30%	Traslado inmediato a Centro de Quemados	Manejarlo en una sala común sin control térmico
Ampollas rotas y piel desprendida	Cubrir con gasas no adherentes	Desbridar quirúrgicamente en pabellón

REGLA DE ORO **Menos de 10%: Stevens-Johnson** — Más de 30%: Necrólisis Epidérmica Tóxica

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **49–54, 57** (págs. 17–18) · solucionario págs. 30–31.

Clase 16.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES TIER 3

16.10 Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

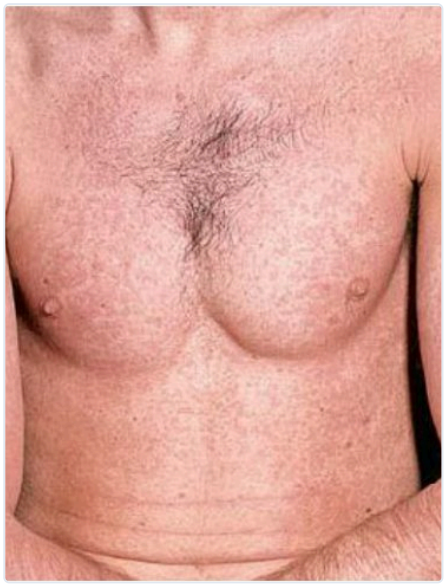
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
1 pregunta real 2013–2025

Alta rentabilidad diagnóstica · Latencia prolongada (2-8 semanas), fiebre persistente, edema facial característico, eosinofilia marcada, atipia linfocitaria y hepatitis con falla multiorgánica

6.01.2.013	Síndrome de hipersensibilidad a drogas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo
6.01.1.025	Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija)	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

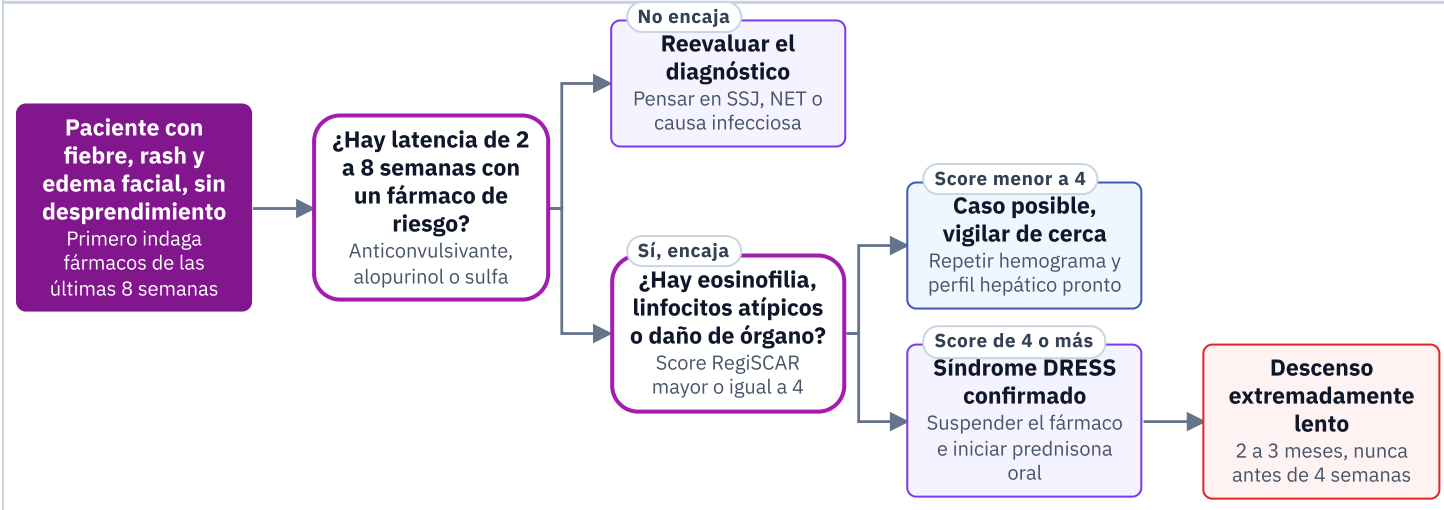
- El DRESS tiene una latencia prolongada y característica de **2 a 8 semanas** tras iniciar el fármaco.
- Los fármacos causales más comunes son Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital y Alopurinol.
- **La tríada cardinal es**: Fiebre alta + Rash confluente con Edema Facial + Linfadenopatías.
- En el laboratorio destaca eosinofilia marcada (> 700-1500/uL) y presencia de linfocitos atípicos.
- El órgano interno más afectado es el hígado (hepatitis tóxica en **75-90%** de los pacientes).
- A diferencia de SSJ/NET, el signo de Nikolsky es negativo y no hay desprendimiento epidérmico difuso.
- El tratamiento de elección es la Prednisona oral (**1 mg/kg**/día) con desescalamiento muy lento (**2-3 meses**).



EXANTEMA DEL TRONCO
Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 40-2

ALGORITMO · DRESS: DE LA SOSPECHA POR LATENCIA AL DESCENSO DE CORTICOIDES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **40–44** (págs. 15–16) · solucionario págs. 28–29.

Clase 16.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES

16.10 Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

PRIORIDAD MEDIA

TABLA 16.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DRESS VS SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON / NET

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	SÍNDROME DRESS	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON / NET
Período de Latencia Farmacológica	Muy prolongado: 2 a 8 semanas (habitual 3-6 sem)	Intermedio: 1 a 3 semanas (7 a 21 días)
Lesión Cutánea Predominante	Exantema morbiliforme confluente + Edema facial intenso	Máculas en diana atípica + Flictenas y ampollas flácidas
Signo de Nikolsky	Negativo (-) habitualmente	Positivo (+) patognomónico
Desprendimiento Epidérmico	Ausente o solo descamación tardía laminar	Presente y extenso (> 10% a > 30% de la piel)
Compromiso de Mucosas	Ausente o leve queilitis (labios secos)	Severo y hemorrágico (≥ 2 mucosas en > 90%)
Hallazgo Hematológico Clave	Eosinofilia marcada (≥ 700-1500/uL) + Linfocitos atípicos	Neutropenia o leucopenia de mal pronóstico
Órgano Blanco Principal	Hígado (hepatitis en 80-90%), Riñón y Miocardio	Piel (gran quemado) y mucosa respiratoria/ocular
Tratamiento Específico	Corticoides sistémicos orales en retiro muy lento (2-3 meses)	Manejo en Centro de Quemados / Soporte hidroelectrolítico

TRAMPAS EUNACOM clase derma-10

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fiebre y rash a las 4 semanas de un fármaco nuevo	Sospechar DRESS y pedir hemograma con perfil hepático	Descartar el fármaco por ser "muy antiguo" para dar alergia
Edema facial con rash confluente, sin ampollas	Pensar en DRESS, Nikolsky negativo	Confundirlo con Stevens-Johnson o NET
Transaminasas elevadas y eosinofilia marcada	Hospitalizar y evaluar función hepática seriada	Atribuirlo solo a una hepatitis viral sin buscar el fármaco

REGLA DE ORO **Pregunta dirigida por fármacos del último mes y medio** — El paciente rara vez lo asocia solo

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El Síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms o Síndrome de Hipersensibilidad Inducida por Fármacos - DIHS) es una reacción de hipersensibilidad retardada potencialmente letal (mortalidad del 5-10%). Su patogenia combina una respuesta inmune mediada por linfocitos T específicos antígeno-fármaco junto con la reactivación masiva de virus de la familia Herpesviridae (particularmente Herpesvirus Humano tipo 6 - HHV-6, HHV-7 y Virus de Epstein-Barr). Se distingue clínicamente por una latencia muy prolongada (de 2 a 8 semanas tras iniciar el fármaco), la presencia de edema facial prominente, fiebre alta, eosinofilia marcada y daño visceral grave, principalmente hepatitis tóxica.

TABLA 16.10.B · ESQUEMA DE TRATAMIENTO Y MONITORIZACIÓN EN SÍNDROME DRESS

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN Y FÁRMACO	DOSIS / DURACIÓN	MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD
1. Retiro de Culpable	Suspensión inmediata de anticonvulsivantes, alopurinol o sulfas	Inmediato (día 0)	Evitar reactividad cruzada con otros anticonvulsivantes aromáticos
2. Corticoterapia Inducción	Prednisona oral (o Metilprednisolona EV si hay falla hepática)	0.5 a 1.0 mg/kg/día por vía oral (o pulsos EV 1 g/d x 3 d)	Control de presión arterial, hemoglucotest y profilaxis con IBP
3. Desescalamiento Lento	Descenso paulatino bisemanal de la dosis de prednisona	Disminución progresiva a lo largo de 8 a 12 semanas (2-3 meses)	Monitorear reaparición de fiebre o eosinofilia por rebote
4. Control Paraclínico	Perfil hepático (GOT/GPT/FA/Bilirrubina), Creatinina y Hemograma	Semanal durante el primer mes, luego cada 2 semanas	Descartar hepatitis fulminante o nefritis intersticial aguda
5. Seguimiento Tardío	Evaluación tiroidea (TSH y T4 libre) a los 2 y 6 meses	Tamizaje de tiroiditis autoinmune post-DRESS	Pesquisar fenómenos autoinmunes tardíos post-reactivación viral

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **40–44** (págs. 15–16) · solucionario págs. 28–29.

Clase 16.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES TIER 3

16.11 Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad semiológica · Diagnóstico diferencial obligatorio en EUNACOM: nivel de la ampolla (intraepidérmica vs subepidérmica), autoantígenos (desmogleína vs hemidesmosomas), signo de Nikolsky y compromiso mucoso

6.01.2.010	Pénfigo y penfigoide	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
6.01.1.020	Pénfigo	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
6.01.5.001	Biopsia de piel	Derivar a especialista		

LO QUE TE PREGUNTAN

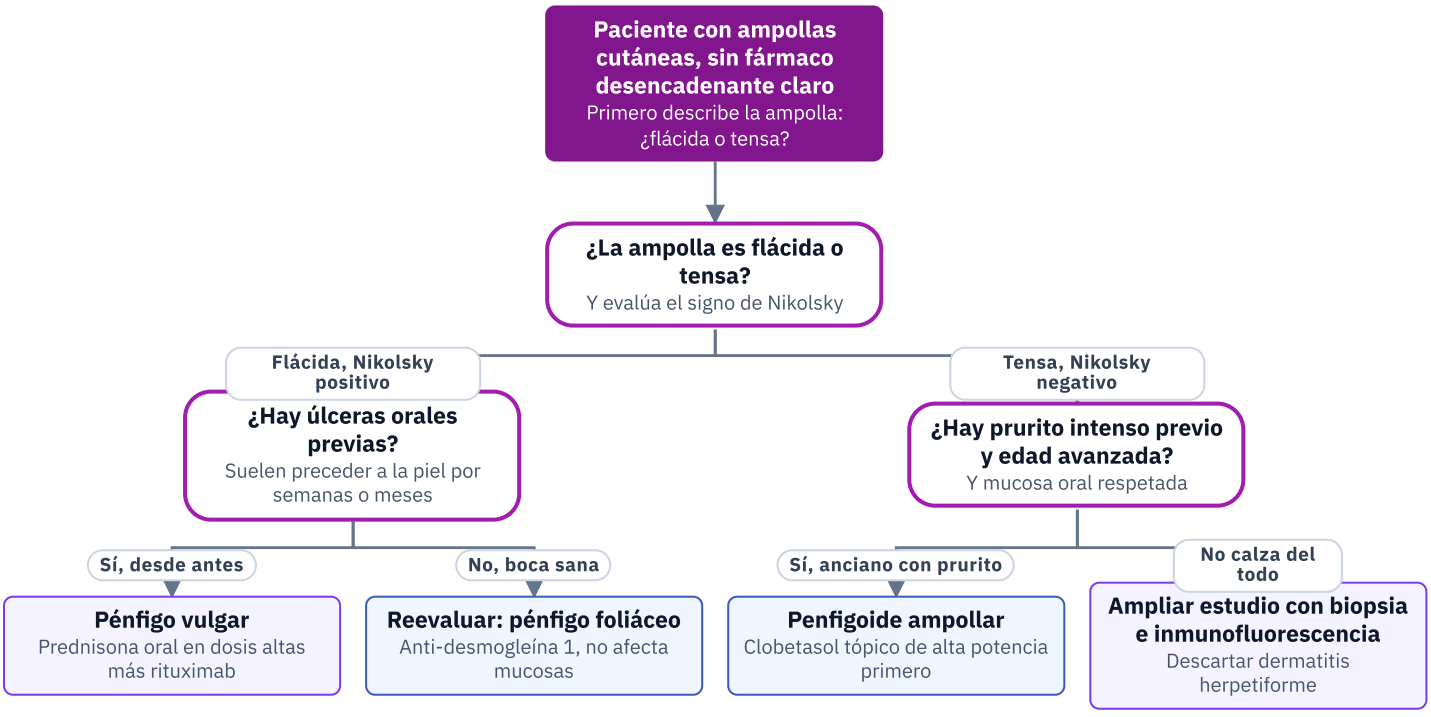
- **Pénfigo Vulgar** = Ampolla flácida intraepidérmica suprabasal + Nikolsky (+) + Afectación mucosa oral inicial.
- **Penfigoide Ampollar** = Ampolla tensa subepidérmica + Nikolsky (-) + Prurito intenso en ancianos + Respeta boca.
- El autoantígeno del pénfigo vulgar es la Desmogleína 3 y 1 (desmosomas / acantolisis).
- El autoantígeno del penfigoide ampollar es BP180 y BP230 (hemidesmosomas / membrana basal).
- La IFD en pénfigo muestra depósito en "red de pescar"; en penfigoide muestra depósito lineal en membrana basal.
- El tratamiento del pénfigo vulgar requiere corticoides orales a dosis altas (**1-1.5 mg/kg**) + Rituximab.
- El tratamiento de primera línea del penfigoide ampollar es el corticoide tópico de alta potencia (Clobetasol).



NIKOLSKY POSITIVO
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5312

ALGORITMO · AMPOLLA AUTOINMUNE: DE LA MORFOLOGÍA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **3, 58–63** (págs. 10, 18–19) · solucionario págs. 23, 32.

Clase 16.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES

16.11 Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★☆☆ PRIORIDAD BAJA

TABLA 16.11 · TABLA COMPARATIVA CLAVE EUNACOM: PÉNFIGO VULGAR VS PENFIGOIDE AMPOLLAR — = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-11

PARÁMETRO	PÉNFIGO VULGAR	PENFIGOIDE AMPOLLAR
Grupo Etario Típico	Adultos de 40 a 60 años	Adultos mayores / Ancianos (> 70-80 años)
Autoantígenos Diana	Desmogleína 3 (mucosa) y Desmogleína 1 (piel)	BP180 (colágeno XVII) y BP230 (hemidesmosomas)
Estructura Afectada	Desmosomas (unión célula-célula)	Hemidesmosomas (unión epidermis-dermis)
Nivel Histológico de la Ampolla	Intraepidérmica suprabasal (con acantolisis)	Subepidérmica (techo epidérmico completo íntegro)
Morfología de la Ampolla	Flácida, pared muy delgada, se rompe rápido	Tensa, pared gruesa resistente, permanece días
Signo de Nikolsky	Positivo (+)	Negativo (-)
Afectación de Mucosa Oral	Muy frecuente (> 70-90%, suele ser el inicio)	Rara (< 10-20%, casi siempre respeta mucosas)
Prurito	Raro o escaso (predomina el dolor y ardor)	Muy intenso (síntoma cardinal predominante)
Inmunofluorescencia Directa	Depósito intraepidérmico en "red de pescar" / "malla"	Depósito lineal continuo en la membrana basal
Tratamiento de Elección	Corticoides orales dosis altas (1-1.5 mg/kg) + Rituximab	Corticoides tópicos potentes (Clobetasol) o Prednisona 0.5 mg/kg

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA — clase derma-11

PARÁMETRO	PÉNFIGO VULGAR	PENFIGOIDE AMPOLLAR
Edad típica	40 a 60 años	Más de 70 a 80 años
Tratamiento inicial	Prednisona oral en dosis altas	Clobetasol tópico de alta potencia
Toma de biopsia	Borde de ampolla reciente en formalina; piel sana vecina en medio de Michel	Una sola muestra, del techo de una ampolla antigua

REGLA DE ORO **Flácida y Nikolsky positivo: pénfigo** — Tensa y Nikolsky negativo: penfigoide

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las enfermedades ampollares autoinmunes representan un clásico evaluado año a año en el examen EUNACOM. La distinción cardinal se establece entre el Pénfigo Vulgar (patología intraepidérmica con acantolisis mediada por autoanticuerpos dirigidos contra desmogleínas desmosómicas) y el Penfigoide Ampollar (patología subepidérmica mediada por autoanticuerpos contra proteínas hemidesmosómicas de la membrana basal: BP180 y BP230). El reconocimiento de las diferencias clínicas (flácida vs tensa, Nikolsky positivo vs negativo, afectación mucosa oral vs indemnidad de mucosas) y de la inmunofluorescencia directa permite responder con total certeza cualquier pregunta del examen.

TABLA 16.11.B · PROTOCOLOS DE INMUNOSUPRESIÓN EN PÉNFIGO VULGAR Y PENFIGOIDE AMPOLLAR

ENFERMEDAD	FASE DE INDUCCIÓN	FASE DE MANTENIMIENTO / AHORRADORES	MONITORIZACIÓN CRÍTICA
Pénfigo Vulgar	Prednisona oral 1.0 a 1.5 mg/kg/día (o pulsos de Metilprednisolona)	Rituximab 1000 mg IV (días 1 y 15) o Azatioprina 2-3 mg/kg/día	Pesquisar infecciones oportunistas, sepsis, diabetes esteroidal
Penfigoide Ampollar (Leve-Mod)	Clobetasol propionato 0.05% crema 20-30 g/día en todo el tegumento	Reducción progresiva de aplicaciones tópicas a lo largo de 4-6 meses	Vigilar atrofia cutánea superficial; menor riesgo sistémico
Penfigoide Ampollar (Grave/Ext)	Prednisona oral 0.5 mg/kg/día	Metotrexato oral 10-15 mg/semana + Ácido fólico o Azatioprina	Hemograma y función hepática seriada por inmunosupresión

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **3, 58–63** (págs. 10, 18–19) · solucionario págs. 23, 32.

Clase 16.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES

16.12 Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

★★★ PRIORIDAD ALTA
4 preguntas reales 2013–2025

6.01.1.010	Eritema polimorfo menor	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo	
6.01.1.031	Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
6.01.4.006	Test TZANCK	Interpreta y emplea	

LO QUE TE PREGUNTAN

- La causa más frecuente de Eritema Multiforme es el Virus Herpes Simple (VHS-1 y 2) en > **70%** de los casos.
- La segunda causa infecciosa relevante es Mycoplasma pneumoniae en niños y jóvenes.
- La lesión elemental patognomónica es la Diana Típica o en Escarapela con 3 zonas concéntricas.
- **Se distribuye de forma simétrica en zonas acrales**: dorso de manos, palmas, antebrazos y rodillas.
- En el eritema multiforme NO hay desprendimiento epidérmico en sábanas y el Nikolsky es NEGATIVO.



DIANAS EN LAS MANOS
Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 15

ALGORITMO · ERITEMA MULTIFORME: DE LA DIANA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

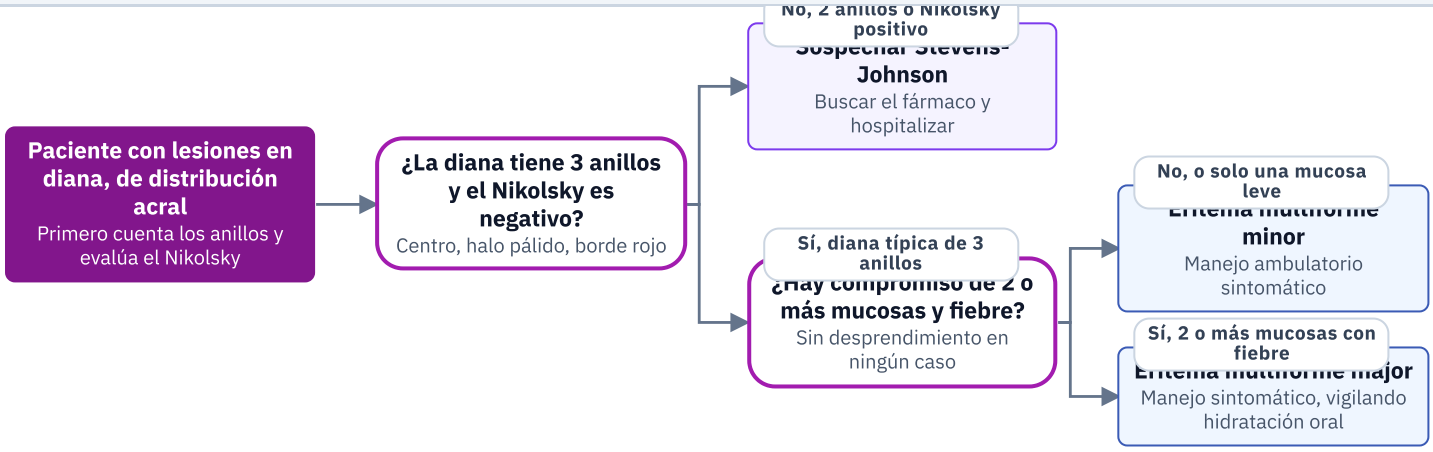


TABLA 16.12 · DIFERENCIAS CARDINALES: ERITEMA MULTIFORME VS SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-12

CRITERIO DIFERENCIAL	ERITEMA MULTIFORME (EM)	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON (SSJ)
Etiología Principal	Infecciosa: Virus Herpes Simple (> 70%) o Mycoplasma	Medicamentosa: Fármacos (Alopurinol, sulfas, anticonvulsivantes)
Morfología de la Diana	Diana típica clásica con 3 anillos concéntricos definidos	Diana atípica con 2 anillos (centro purpúrico/ampollar plano)
Distribución Anatómica	Acral: dorso de manos, antebrazos, codos, rodillas	Centrípeta y axial: tronco, tórax anterior, cara y cuello
Desprendimiento Epidérmico	Ausente (0% de superficie corporal desprendida)	Presente (< 10% en SSJ puro, > 30% en NET)
Signo de Nikolsky	Negativo (-)	Positivo (+) en piel perilesional
Compromiso de Mucosas	Ausente o leve a moderado (oral); buen estado general	Severo, extenso, hemorrágico y con costras labiales
Pronóstico y Manejo	Autolimitado en 2-4 semanas; manejo ambulatorio en APS	Grave con riesgo vital; requiere hospitalización en UCI/Quemados

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase derma-12

CRITERIO	ERITEMA MULTIFORME	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON
Nikolsky y desprendimiento	Negativo, sin desprendimiento	Positivo, con desprendimiento

REGLA DE ORO — **Diana de 3 zonas concéntricas** — Acral, simétrica, tras un herpes labial

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **64–69** (págs. 19–20) · solucionario pág. 33.

Clase 16.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS TIER 3

16.13 Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta en EUNACOM · Preguntas clave sobre técnica de biopsia diagnóstica e índice pronóstico

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Piel en personas de 15 años y más · Notificación Obligatoria.

6.01.1.017 Melanoma maligno — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.01.5.001 Biopsia de piel — Derivar a especialista

6.01.4.002 Dermatoscopía — Emplea informe

LO QUE TE PREGUNTAN

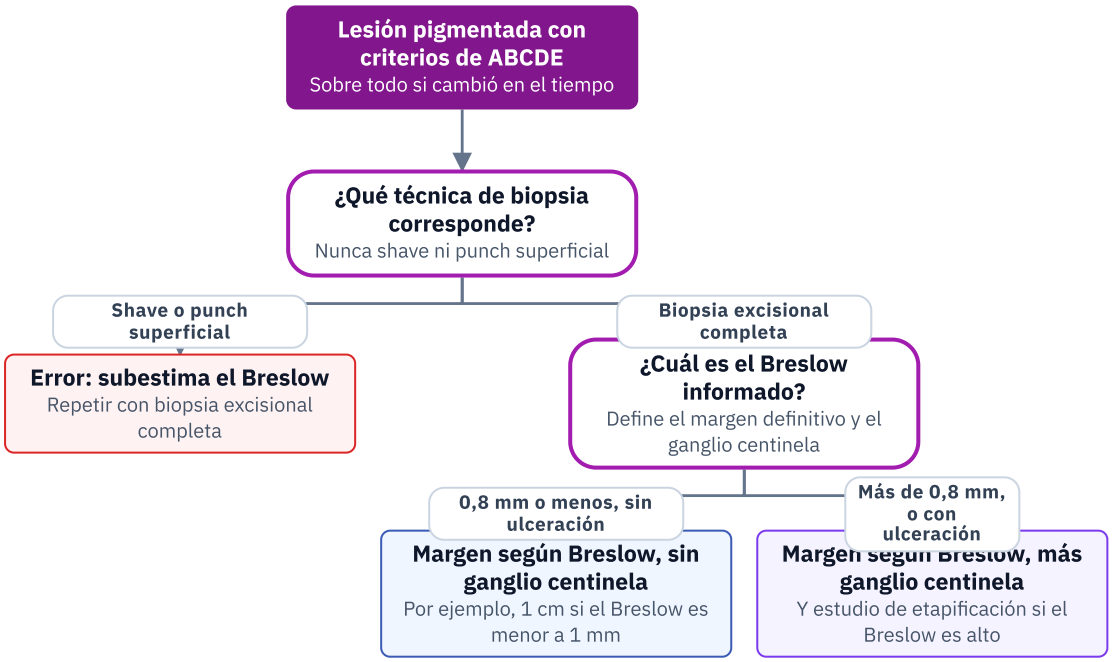
- La regla del ABCDE (Asimetría, Bordes, Color heterogéneo, Diámetro > **6 mm**, Evolución) es la herramienta clínica de tamizaje cardinal para melanoma.
- La biopsia de elección de toda lesión sospechosa de melanoma es la BIOPSIA EXCISIONAL COMPLETA con margen estrecho de **1 a 2 mm** e hipodermis.
- Las biopsias por rasurado (shave) o punch están contraindicadas porque mutilan la muestra e impiden medir con exactitud el espesor de Breslow.
- El Índice de Breslow (espesor tumoral en milímetros) es el factor pronóstico individual más importante para el melanoma localizado.
- El margen de ampliación quirúrgica definitiva se define según el Breslow: in situ (**0.5 cm**), **≤ 1 mm** (**1 cm**), **1-2 mm** (**1-2 cm**), > **2 mm** (**2 cm**).
- La biopsia de ganglio centinela está formalmente indicada en todo melanoma con espesor de Breslow > **0.8 mm** (o < **0.8 mm** con ulceración).



NEVO CONGÉNITO GRANDE
Manual AMIR Dermatología, p. 99

ALGORITMO · MELANOMA: DE LA SOSPECHA A LA AMPLIACIÓN DE MÁRGENES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **70–72** (pág. 20) · solucionario págs. 33–34.

Clase 16.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

16.13 Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 16.13 · SUBTIPOS DE MELANOMA MALIGNO Y CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA

SUBTIPO	FRECUENCIA GLOBAL / CHILE	LOCALIZACIÓN TÍPICA	FASE DE CRECIMIENTO	CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Extensión Superficial	70% caucásicos	Espalda (hombres), Piernas (mujeres)	Radial prolongada antes de vertical	Mácula/placa policromática asimétrica; el más frecuente
Nodular	15%	Cualquier zona anatómica	Vertical pura desde el inicio	Nódulo azul-negro cupuliforme, muy agresivo, Breslow alto
Léntigo Maligno Melanoma	10%	Cara, mejillas, nariz en ancianos	Radial muy lenta (años/décadas)	Asociado a daño solar crónico continuo (peca de Hutchinson)
Lentiginoso Acral	5% caucásicos (>50% en Chile/latino)	Palmas, plantas, subungueal	Radial y vertical	No UV-dependiente; Signo de Hutchinson periungueal

TRAMPAS EUNACOM clase derma-13

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Lesión con ABCDE positivo	Biopsia excisional completa con margen estrecho e hipodermis	Biopsia por shave o punch "para no dejar cicatriz"
Breslow de 0,6 milímetros, sin ulceración	Margen de 1 centímetro, sin ganglio centinela	Pedir ganglio centinela igual
Breslow mayor a 0,8 milímetros, o con ulceración	Ganglio centinela obligatorio	Omitirlo porque "no se palpan adenopatías"

REGLA DE ORO **ABCDE, y sobre todo la E** — Cambio dinámico, o lesión nueva en el adulto

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El melanoma maligno es el tumor cutáneo con mayor letalidad por su elevado potencial metastásico precoz. En el EUNACOM se evalúan con absoluta certeza tres conceptos fundamentales: 1) la regla del ABCDE para la sospecha clínica; 2) la técnica de biopsia adecuada, que DEBE SER EXCISIONAL COMPLETA con margen mínimo de 1 a 2 mm incluyendo hipodermis (la biopsia por afeitado/shave o punch está formalmente contraindicada porque mutila la medición del espesor); y 3) el Índice de Breslow (profundidad de invasión en milímetros medido desde la capa granulosa), que es el factor pronóstico individual más importante y determina la ampliación definitiva de márgenes quirúrgicos y la indicación de biopsia de ganglio centinela.

TABLA 16.13.B · MANEJO MÉDICO Y QUIRÚRGICO INTEGRAL DEL MELANOMA MALIGNO (GES)

ESCENARIO CLÍNICO	INTERVENCIÓN PRIMARIA	ESTUDIO DE ETAPIFICACIÓN	TERAPIA ADYUVANTE / SISTÉMICA
Lesión Sospechosa Inicial	Biopsia excisional completa con margen 1-2 mm	Dermatoscopía digital + estudio histopatológico	No aplica
Melanoma Localizado (T1-T4 N0)	Ampliación de márgenes (1 a 2 cm) + Ganglio Centinela	TAC tórax-abdomen-pelvis o PET-CT si T3-T4	Interferón-alfa (histórico) o seguimiento estrecho
Compromiso Ganglionar (N+)	Linfadenectomía regional terapéutica si macroscópico	PET-CT o RMN cerebral + TAC TAP	Inmunoterapia (Nivolumab / Pembrolizumab) o Terapia dirigida
Melanoma Metastásico (Estadio IV)	Manejo oncológico sistémico según mutación BRAF V600E	RMN cerebral + PET-CT completo	Inhibidores BRAF/MEK (Dabrafenib+Trametinib) o anti-PD-1

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **70–72** (pág. 20) · solucionario págs. 33–34.

Clase 16.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

16.14 Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Piel en personas de 15 años y más.

6.01.1.003	Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
6.01.3.001	Fotoprotección	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Carcinoma Basocelular (CBC) es el cáncer cutáneo más frecuente de todos; se caracteriza por pápula perlada con telangiectasias.
- El CBC tiene un riesgo de metástasis prácticamente nulo (<**0.01%**), pero gran poder de destrucción local invasiva.
- El Carcinoma Espinocelular (CEC) se manifiesta como nódulo o placa queratósica descamativa indurada sobre queratosis actínica previa.
- El CEC SÍ tiene potencial metastásico linfático regional (**2-5%** habitual, hasta **15%** en labio inferior y pabellón auricular).
- Los pacientes con trasplante de órganos bajo inmunosupresión crónica tienen un riesgo masivamente aumentado de CEC agresivo.
- La Cirugía Micrográfica de Mohs es el tratamiento de elección para tumores en áreas cosméticamente críticas faciales o con bordes mal definidos.



BASOCELULAR NODULAR
Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 99

ALGORITMO · DEL DAÑO SOLAR A LA CIRUGÍA: BASOCELULAR VERSUS ESPINOCELULAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

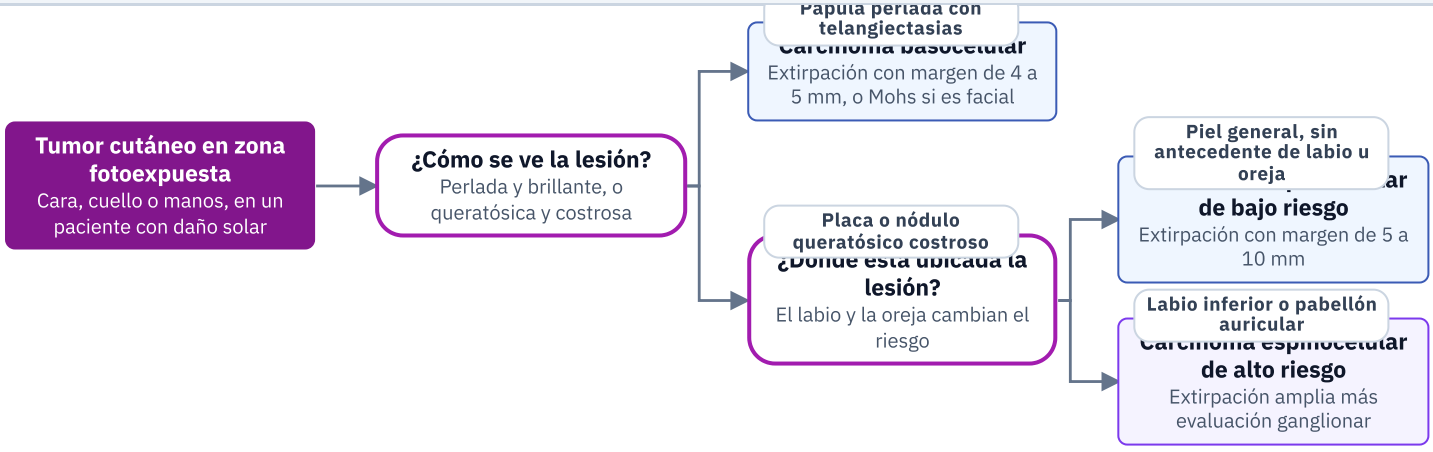


TABLA 16.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: CARCINOMA BASOCELULAR VS CARCINOMA ESPINOCELULAR

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-14

PARÁMETRO	CARCINOMA BASOCELULAR (CBC)	CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC)
Frecuencia Relativa	75 - 80% (el más frecuente)	15 - 20%
Lesión Precursora	Ninguna conocida (aparece de novo)	Queratosis actínica / Queilitis actínica
Aspecto Clínico Típico	Pápula translúcida perlada con telangiectasias y borde arrollado	Placa/nódulo queratósico costroso indurado o cuerno cutáneo
Compromiso de Mucosas	Excepcional (nunca en mucosas puras)	Frecuente (labio inferior, lengua, mucosa genital)
Riesgo de Metástasis	Prácticamente nulo (< 0.01%)	Significativo (2 - 5% en piel, > 15% en labio/oreja)
Tratamiento Estándar	Extirpación con margen 4-5 mm o Mohs	Extirpación con margen 5-10 mm + evaluación ganglionar

REGLA DE ORO **Basocelular: perlado, con telangiectasias** — Espinocelular: queratósico, indurado

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **76–81** (pág. 21) · solucionario págs. 34–35.

Clase 16.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

16.15 Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
1 pregunta real 2013–2025

6.01.1.029 Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La queratosis actínica es la lesión premaligna cutánea más común y es precursora directa del Carcinoma Espinocelular.
- Clínicamente se caracteriza por máculas eritematosas con escamas secas adherentes que al tacto se sienten ásperas como papel de lija.
- La presencia de induración en la base de una queratosis actínica obliga a sospechar progresión a carcinoma espinocelular invasor y realizar biopsia.
- El cuerno cutáneo es una hiperqueratosis compacta en cuya base frecuentemente subyace una queratosis actínica o un CEC.
- Para lesiones múltiples en una zona fotoexpuesta extensa se debe tratar el 'campo de cancerización' con Imiquimod o 5-Fluorouracilo tópico.



QUERATOSIS ACTÍNICA
Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 96

ALGORITMO · QUERATOSIS ACTÍNICA: DEL TACTO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

Mácula áspera en zona fotoexpuesta
Se palpa antes de verse

↓

¿La base está indurada, o hay varias lesiones?
La induración cambia todo el plan

- Base indurada, dolor o crecimiento rápido → **Sospechar progresión a carcinoma espinocelular**
  Biopsia excisional o incisional
- Sin induración: una o pocas lesiones → **Crioterapia con nitrógeno líquido**
  Tratamiento focal de elección
- Sin induración: múltiples lesiones en la misma zona → **Tratamiento de campo: Imiquimod o 5-Fluorouracilo**
  Más fotoprotección estricta

TABLA 16.15 · MODALIDADES TERAPÉUTICAS EN QUERATOSIS ACTÍNICAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-15

MODALIDAD	FÁRMACO / TÉCNICA	INDICACIÓN CLÍNICA	EFECTO ADVERSO ESPERABLE
Terapia Dirigida a Lesión	Crioterapia con Nitrógeno Líquido	Lesiones aisladas, gruesas o hiperqueratósicas	Ampolla, costra, hipopigmentación residual
Terapia de Campo Tópica	Imiquimod al 5% crema (2-3 veces/sem x 4-6 sem)	Múltiples lesiones en área extensa (frente/cuero cabelludo)	Eritema intenso, erosiones, costras (señal de eficacia)
Terapia de Campo Tópica	5-Fluorouracilo (5-FU) 5% crema (2 veces/día x 3-4 sem)	Múltiples lesiones en cara y dorso de manos	Inflamación marcada, descamación, ardor
Cirugía / Biopsia	Biopsia excisional o curetaje	Lesión con base indurada, dolor o rápido crecimiento	Cicatriz (descartar carcinoma espinocelular invasor)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase derma-15

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Una o dos lesiones aisladas	Crioterapia con nitrógeno líquido	Iniciar Imiquimod para una sola lesión
Múltiples lesiones en frente y cuero cabelludo	Tratamiento de campo con Imiquimod o 5-Fluorouracilo	Congelar lesión por lesión, sin tratar el campo
Cuerno cutáneo en cualquier paciente	Biopsiar siempre la base	Asumir que es benigno por su forma

REGLA DE ORO **Se palpa antes de verse** — Mácula áspera en zona fotoexpuesta

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **82–84** (págs. 21–22) · solucionario pág. 35.

Clase 16.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

6.01.1.018	Micosis superficiales	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
6.01.1.019	Pediculosis	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
2.01.1.109	Ectoparasitosis	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
6.01.1.027	Sarna	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
6.01.4.004	Micológico directo de piel, pelos y uñas	Interpreta y emplea		

+ 5 códigos relacionados: 2.01.1.110 · 1.04.4.003 · 6.01.1.022 · 6.01.1.023 · 6.01.4.001

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Tiña Capitis SIEMPRE requiere tratamiento antimicótico oral (Griseofulvina o Terbinafina); los antifúngicos tópicos NO curan la tiña capitis.
- La Tiña Inguinal típicamente respeta el escroto, a diferencia del intértrigo candidiásico que compromete escroto con lesiones satélites.
- La Pitiriasis Versicolor presenta el signo de la uñada positivo y en el examen con KOH se aprecian hifas y esporas ('espaguetis con albóndigas').
- El prurito nocturno intratable con surcos en espacios interdigitales y muñecas es el sello clínico de la Escabiosis.
- El tratamiento de la escabiosis es Permetrina al **5%** en crema aplicada del cuello a los pies y repetida a los **7 días**.

ALGORITMO · INFECCIONES CUTÁNEAS COMUNES: DE LA LESIÓN AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

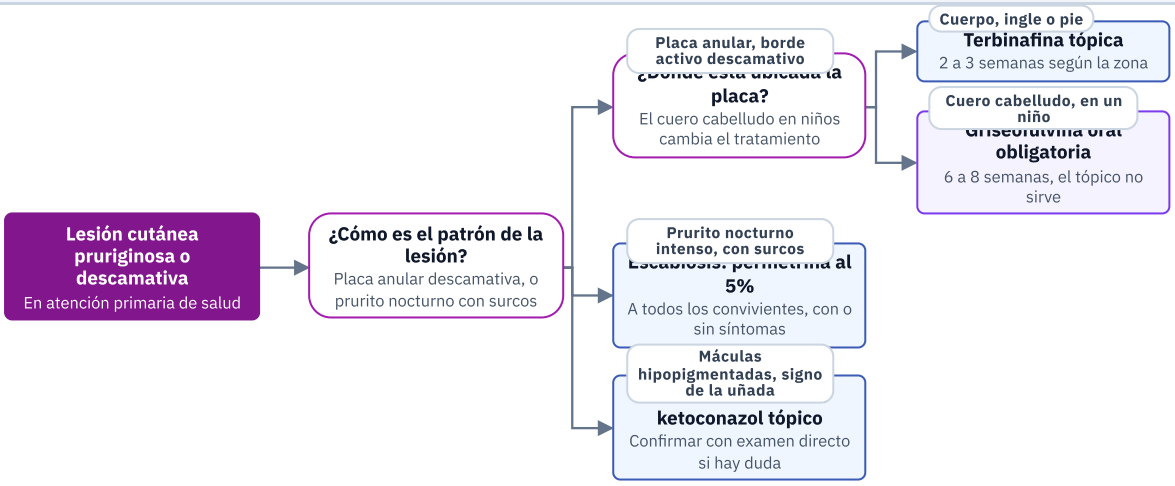


TABLA 16.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES CUTÁNEAS COMUNES

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-16

INFECCIÓN	AGENTE CAUSAL	CLÍNICA CARDINAL	DIAGNÓSTICO DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA
Tiña del Cuerpo / Pie	Trichophyton rubrum / mentagrophytes	Placa anular borde activo descamativo	Clínica + Examen directo KOH	Terbinafina tópica 1% c/12h x 2-3 sem
Tiña de la Cabeza	Microsporum canis / Trichophyton	Placa alopécica con pelos rotos en niños	Examen con lámpara de Wood + KOH/cultivo	GRISEOFULVINA ORAL x 6-8 semanas (No tópicos)
Pitiriasis Versicolor	Malassezia furfur / globosa	Máculas hipo/hipercrómicas descamativas	Signo de la uñada + KOH (espaguetis)	Ketoconazol shampoo 2% tópico x 2 semanas
Escabiosis (Sarna)	Sarcoptes scabiei hominis	Prurito nocturno, surcos interdigitales	Clínica + Acarotest directo	PERMETRINA 5% crema a TODOS los convivientes

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase derma-16

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Placa anular en el tronco, borde activo	Terbinafina tópica, 2 a 3 semanas	Corticoide tópico por sospecha de eccema
Máculas descamativas hipopigmentadas en tronco	Ketoconazol tópico, con KOH que confirma	Confundir con vitíligo o pitiriasis alba

REGLA DE ORO **Tópico no llega a la raíz del pelo** — Griseofulvina o terbinafina oral

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **21, 55, 73, 85–90** (págs. 13, 17, 20, 22) · solucionario págs. 26, 31, 34, 36.

Clase 16.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

16.17 Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares

★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

6.01.1.028	Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
6.01.1.013	Hemangiomas cutáneos infantiles	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.111	Malformaciones vasculares cutáneas	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Queratosis seborreica**: placa verrugosa «pegada» del adulto mayor, benigna; la aparición brusca de muchas (Leser-Trélat) sugiere neoplasia interna.
- **Quiste epidérmico**: nódulo con punctum; se extirpa completo y fuera de la fase inflamatoria. Lipoma sospechoso (más de **5 cm**, profundo o doloroso): resonancia y biopsia.
- Queloide sobrepasa los bordes de la herida y no regresa (triamcinolona intralesional); la cicatriz hipertrófica no los sobrepasa y tiende a regresar.
- **Hemangioma infantil**: no está al nacer, crece **3 a 5 meses** y luego involuciona. La mayoría se observa.
- Propranolol oral (**2 a 3 mg/kg**/día por **6 a 12 meses**) para hemangiomas periorbitarios, de vía aérea, ulcerados o desfigurantes; contraindicado en asma, bradicardia y bloqueo AV.

ALGORITMO · LESIÓN BENIGNA O VASCULAR DE LA PIEL: CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

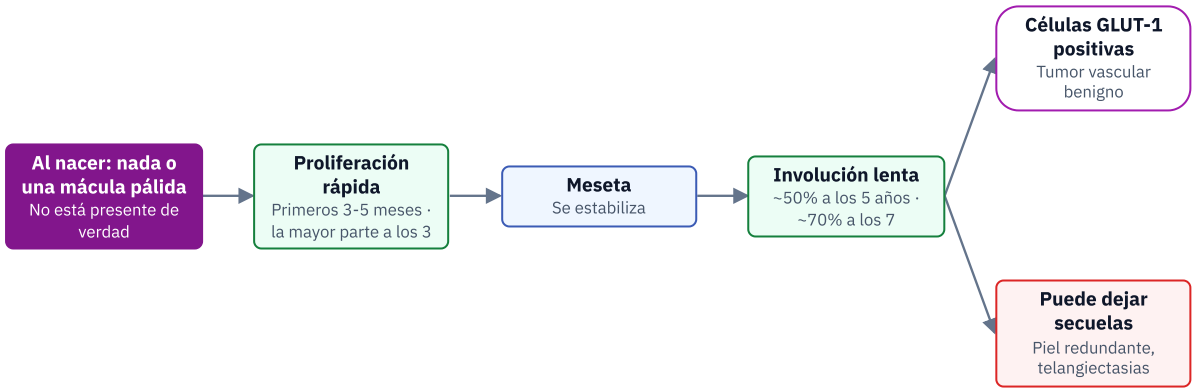


TABLA 16.17 · HEMANGIOMA INFANTIL VERSUS MALFORMACIONES VASCULARES Y LESIONES BENIGNAS FRECUENTES

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-17

LESIÓN	CUÁNDO APARECE / DATO CLAVE	EVOLUCIÓN	CONDUCTA EN APS
Hemangioma infantil	Semanas tras el nacimiento · GLUT-1 positivo · placa roja en fresa o nódulo azulado	Crece 3 a 5 meses y luego involuciona en años	Observar · propranolol si es periocular, ulcerado, de vía aérea o desfigurante · 5 o más: ecografía abdominal
Mancha salmón	Presente al nacer · nuca, frente y párpados · pálida con la digitopresión	Frente y párpados desaparecen en 1 a 2 años	Tranquilizar · sin estudio ni tratamiento
Mancha en vino de Oporto	Presente al nacer · unilateral en cara · no desaparece	Se oscurece y engruesa con la edad	Láser (derivar) · V1 afectado: descartar Sturge-Weber (RM, oftalmología)
Malformación venosa o linfática	Masa blanda azulada compresible o quística	Crece con el niño y no involuciona	Ecodoppler o RM · derivar
Queratosis seborreica	Adulto mayor · placa verrugosa «pegada» café a negra	Benigna, sin malignización	Observar · crioterapia si molesta · biopsia si hay duda
Quiste epidérmico	Nódulo móvil con punctum central	Puede inflamarse o abscedarse	Extirpación completa de la pared fuera de la fase inflamatoria

REGLA DE ORO **Queloide sobrepasa los bordes** — Hipertrófica no, y regresa

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **19–20, 56** (págs. 12, 18) · solucionario págs. 25, 31.

Clase 16.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

16.18 Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

6.01.2.008	Loxocelismo	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
6.01.3.002	Higiene de la vivienda y profilaxis del loxoscelismo	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- La araña de rincón (Loxosceles laeta) vive dentro de las casas, es nocturna y muerde al ser aplastada contra la piel, al dormir o vestirse.
- Mordedura casi indolora; a las **6 a 12 horas**, placa livedoide con ampolla hemorrágica; luego escara negra y úlcera de cicatrización lenta.
- **Forma cutánea (80 a 90%)**: reposo, frío local, elevación, analgesia, aseo y profilaxis antitetánica; no escisión precoz, debridar la escara tardíamente.
- **Forma cutáneo-visceral (hasta 72 horas)**: fiebre, exantema, hemólisis con orina oscura, trombocitopenia y falla renal; hospitalizar con hidratación y corticoide endovenoso.
- Suero antiloxosceles solo en las primeras **24 a 48 horas** y con criterio del toxicólogo; el CITUC asesora las **24 horas**.
- **Prevención**: aspirar rincones, cama separada del muro, revisar ropa y calzado antes de usarlos, sellar grietas y evitar acumular objetos.



ARAÑA DE RINCÓN
Nelson 22.ª ed., Fig. 768.4

ALGORITMO · MORDEDURA DE ARAÑA DE RINCÓN: CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

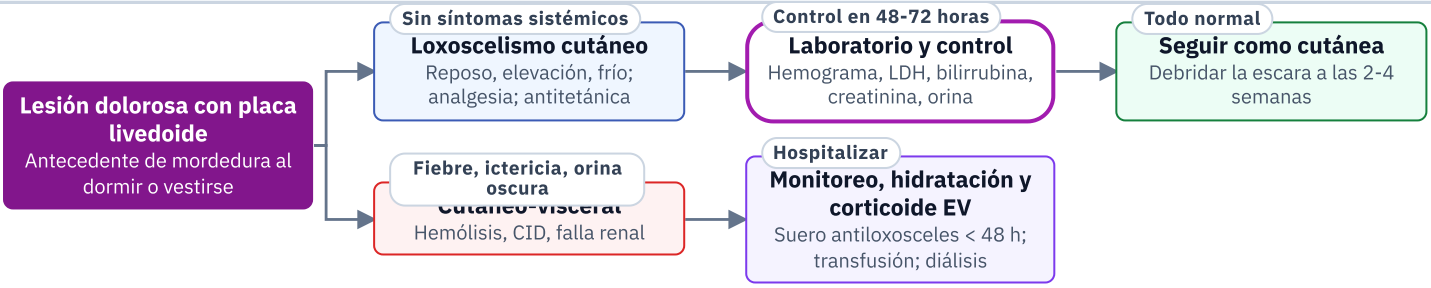


TABLA 16.18 · LOXOSCELISMO CUTÁNEO VERSUS CUTÁNEO-VISCERAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE DERMA-18

PARÁMETRO	CUTÁNEO (80-90%)	CUTÁNEO-VISCERAL (1-15%)
Inicio de los síntomas	Dolor y eritema en 2 a 8 horas	Síntomas sistémicos en las primeras 6 a 72 horas
Lesión	Placa livedoide, ampolla hemorrágica y escara	Igual, con o sin lesión cutánea llamativa
Clínica sistémica	Ausente	Fiebre, exantema, ictericia, orina oscura
Laboratorio	Normal	Anemia hemolítica, LDH elevada, trombocitopenia, coagulopatía, creatinina elevada
Manejo	Reposo, frío, analgesia, curaciones; debridar la escara tardíamente	Hospitalizar · hidratación · corticoide endovenoso · suero antiloxosceles · diálisis si hay falla renal
Pronóstico	Úlcera de cicatrización lenta con cicatriz	Riesgo vital, mayor en niños

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase derma-18

PARÁMETRO	CUTÁNEO (80-90%)	CUTÁNEO-VISCERAL (1-15%)
Cirugía precoz o calor local	Empeora la lesión	Error: escisión o calor

REGLA DE ORO **Araña de rincón: dentro de casa, nocturna** — Muerde al ser aplastada

PRACTICA **Libro Gordo Dermatología**, preguntas **22–23, 74** (págs. 13, 20) · solucionario págs. 26, 34.

Clase 16.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 18 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS	
16.1 Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	pág. 3
Vesícula < **0.5 cm** líquida; Ampolla > **0.5 cm** líquida.	CORTE
Mácula: menor a **1 cm** — Efélides, petequias	CORTE
16.2 Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína	pág. 4
Acné inflamatorio moderado-severo = Tetraciclinas orales (Doxiciclina **100 mg**/día) por **8 a 12 semanas**.	DOSIS
16.3 Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico	pág. 5
Doxiciclina oral en dosis antiinflamatoria — Si es moderada a severa, por **8 a 12 semanas**	DOSIS
BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS	
16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas	pág. 7
Eritema y escama en más del **90%** — Psoriasis, atopia, toxidermia, Sézary	CORTE
Rigidez matinal y dactilitis — Más de **30 minutos**; entesitis en talón y planta	TIEMPO
16.6 Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación	pág. 9
Tronco y extremidades: mediana a alta potencia — Betametasona o mometasona, por **7 a 14 días**	META
16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)	pág. 10
Cambio frecuente y barrera de zinc — Cada **2 a 3 horas**; óxido de zinc o vaselina	TIEMPO
Pruebas del parche, lectura a las 48 y a las **96 horas** — Positivas en la alérgica	TIEMPO
16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	pág. 11
Segunda línea: cuadruplicar la dosis — Si no hay control en **2 a 4 semanas**	DOSIS
Menos de **24 horas**, sin marca — Si es fijo, piensa en vasculitis urticariana	TIEMPO
BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES	
16.9 Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	pág. 12
Edad de **40 años** o más — Menor capacidad de regeneración epitelial	CORTE
Puede llegar al 70 u **80%** de la piel — Mortalidad de 30 a 50 por ciento	CORTE
Menos de **10%**: Stevens-Johnson — Más de **30%**: Necrólisis Epidérmica Tóxica	CORTE
Nikolsky positivo, mucosas respetadas — Sin dianas atípicas; cura en **5 a 7 días**	TIEMPO
16.10 Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos	pág. 13
Latencia: **2 a 8 semanas** versus 1 a 3 — El DRESS siempre es más tardío	TIEMPO
Bajar rápido provoca recaída fulminante — Nunca antes de las **4 semanas**	TIEMPO
En el laboratorio destaca eosinofilia marcada (> 700-1500/uL) y presencia de linfocitos atípicos.	CORTE
16.11 Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	pág. 15
Prednisona **1 a 1,5 mg/kg**/día — Antes de los corticoides, mortalidad mayor a **70%**	DOSIS
Grupo Etario Típico · Adultos de **40 a 60 años** · Adultos mayores / Ancianos (> **70-80 años**)	CORTE
16.12 Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	pág. 17
Vesículas en racimo tras ardor y prurito — Costras a los **7 a 10 días**	TIEMPO
Pápulas perladas umbilicadas de **2 a 5 mm** — Niños; en adultos, genital o VIH	CORTE
Recurrente por VHS: aciclovir **6 meses** — Previene más del **80%** de las recaídas	TIEMPO
Ácido salicílico y crioterapia — Derivar si no responde en **3 meses** o hay condilomas	TIEMPO
BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS	
16.13 Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	pág. 18
Sospechosa: biopsia excisional y derivar — Margen de **1 a 3 mm**	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
16.18 Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda (cont.)	pág. 24
Extensión superficial: **70%** — Espalda en hombres, piernas en mujeres	CORTE
Léntigo maligno melanoma: **10%** — Cara de ancianos, evoluciona en años	CORTE
16.14 Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	pág. 20
Menores de **6 meses**: sin sol directo — Nunca camas solares	TIEMPO
Frecuencia Relativa · **75 - 80%** (el más frecuente) · **15 - 20%**	CORTE
Escisión con márgenes — CBC: **4 mm**; CEC: **4 a 6 mm**; alto riesgo: **6 a 10 mm**	CORTE
16.15 Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos	pág. 21
Hasta **5%** invade — Por eso se trata	CORTE
16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	pág. 22
Pediculosis: al **1%** — Escabiosis: al **5%**	CORTE
25 a 30 °C por **2 a 4 semanas** — Hasta 6 en uñas	TIEMPO
Del cuello a los pies — Dejar actuar de **8 a 12 horas**, repetir a los **7 días**	TIEMPO
Lavar la ropa con agua caliente — O guardarla en bolsa cerrada por **72 horas**	TIEMPO
16.17 Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares	pág. 23
Triamcinolona intralesional — **10-40 mg**/mL cada **4-6 semanas** · silicona	DOSIS
Pápula firme pardo-rosada — **0,5-1 cm** · signo del hoyuelo	CORTE
Mácula rosada mal delimitada — **40-70%** de los recién nacidos	CORTE
Respeta los bordes de la herida — Primeras semanas · regresa en **1-2 años**	TIEMPO
16.18 Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda	pág. 24
Primeras **24-48 horas** — Por indicación del toxicólogo	TIEMPO
Extensión gravitacional en **24-72 horas** — Escara negra seca	TIEMPO
Cama a **20 cm** del muro — Ropa de cama que no cuelgue al piso	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
16.2 Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína		pág. 4
Antibióticos orales · Tetraciclinas	**Doxiciclina o minociclina**	Por **8 a 12 semanas**
16.3 Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico		pág. 5
Pápulo-pustulosa	**Metronidazol o ivermectina tópica**	Primera línea si es leve
Pápulo-pustulosa	**Doxiciclina oral en dosis antiinflamatoria**	Si es moderada a severa, por **8 a 12 semanas**
16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas		pág. 7
Psoriasis leve	**Corticoide potente más calcipotriol**	Clobetasol o betametasona, más un análogo de vitamina D
Líquen plano · Conducta inicial	**Clobetasol tópico y antihistamínico**	Corticoide oral solo por el especialista
16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)		pág. 10
Escamas grasosas donde hay más sebo · Antifúngico tópico	**Champú con ketoconazol al 2 por ciento**	O sulfuro de selenio, dos a tres veces por semana
Dermatitis del pañal · Tratamiento y prevención	**Hidrocortisona 1% corta; antifúngico si hay Candida**	Nunca corticoides potentes ni asociaciones
16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos		pág. 11
Escalonamiento internacional	**Tercera línea: omalizumab**	Anticuerpo monoclonal anti inmunoglobulina E
16.9 Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)		pág. 12
Conducta inicial	**Cloxacilina endovenosa**	Vancomicina si hay sospecha de SARM; clindamicina asociada
16.11 Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)		pág. 15
Pénfigo vulgar	**Prednisona 1 a 1,5 mg/kg/día**	Antes de los corticoides, mortalidad mayor a **70%**
Pénfigo vulgar	**Rituximab de primera línea**	Anticuerpo anti-CD20, ahorra corticoides
16.12 Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple		pág. 17
Aciclovir · Herpes labial activo en el brote agudo	**Aciclovir oral en ese episodio**	
Aciclovir · Recurrente: 3 a 5 brotes al año	**Aciclovir profiláctico continuo por 6 meses**	
16.15 Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos		pág. 21
Tratamiento de campo · Imiquimod al 5%	**Inmunomodulador: activa la respuesta inmune local**	
16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis		pág. 22
Ketoconazol tópico	**Champú de ketoconazol al 2%**	O terbinafina tópica, por **2 semanas**
Pediculosis · Nivel completo	**Resistencia: dimeticona 4% o ivermectina**	Ivermectina **200 µg**/kg en 2 dosis, en refractarios
16.18 Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda		pág. 24
Forma cutáneo-visceral · Medidas	**Corticoide endovenoso precoz**	Transfundir si hay anemia grave

GES de Dermatología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud: Psoriasis Moderada a Grave en personas de 15 años y más (GES N° 84)**

Tema **16.5** · Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas
`6.01.1.024` · `1.11.1.001` · `6.01.1.015`
pág. **7**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Piel en personas de 15 años y más · Notificación Obligatoria.**

Tema **16.13** · Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos
`6.01.1.017` · `6.01.5.001` · `6.01.4.002`
pág. **18**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Piel en personas de 15 años y más.**

Tema **16.14** · Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)
`6.01.1.003` · `6.01.3.001`
pág. **20**

Sin garantía GES específica (15 temas): 16.1 · 16.2 · 16.3 · 16.4 · 16.6 · 16.7 · 16.8 · 16.9 · 16.10 · 16.11 · 16.12 · 16.15 · 16.16 · 16.17 · 16.18. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

3 temas · ★★★

- ★★★ **16.16** Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis 22
- ★★★ **16.8** Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos 11
- ★★★ **16.17** Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares 23

Practica: Libro Gordo Dermatología, preguntas 19–21, 45–48, 55–56, 73, 75, 85–90.

DÍA 2

3 temas · ★★★

- ★★★ **16.5** Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas 7
- ★★★ **16.7** Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa) 10
- ★★★ **16.9** Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) 12

Practica: Libro Gordo Dermatología, preguntas 1, 24–29, 33–37, 49–54, 57.

DÍA 3

3 temas · ★★★

- ★★★ **16.12** Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple 17
- ★★☆ **16.13** Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos 18
- ★★☆ **16.14** Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) 20

Practica: Libro Gordo Dermatología, preguntas 64–72, 76–81.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **16.6** Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación 9
- ★★☆ **16.18** Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda 24
- ★★☆ **16.1** Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel 3

Practica: Libro Gordo Dermatología, preguntas 2, 4–8, 22–23, 30–32, 74.

DÍA 5

3 temas · ★★

- ★★☆ **16.3** Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico 5
- ★★☆ **16.4** Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno 6
- ★★☆ **16.10** Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos 13

Practica: Libro Gordo Dermatología, preguntas 12–18, 40–44.

DÍA 6

3 temas · ★★

- ★★☆ **16.15** Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos 21
- ★☆☆ **16.2** Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína 4
- ★☆☆ **16.11** Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) 15

Practica: Libro Gordo Dermatología, preguntas 3, 9–11, 58–63, 82–84.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 25
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 16.5 · 16.7 · 16.8 · 16.9 · 16.12 · 16.16 · 16.17
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Dermatología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 7 temas

12 16.16. Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis 22
10 16.8. Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos 11
10 16.17. Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares 23
6 16.5. Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas GES 7
6 16.7. Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa) 10
4 16.9. Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) 12
4 16.12. Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple 17

★★ Prioridad media · 9 temas

3 16.13. Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos GES 18
3 16.14. Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) GES 20
2 16.6. Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación 9
2 16.18. Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda 24
1 16.1. Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel 3
1 16.3. Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico 5
1 16.4. Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno 6
1 16.10. Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos 13
1 16.15. Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos 21

★ Prioridad baja · 2 temas

0 16.2. Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína 4
0 16.11. Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) 15